Kusum preparatlari

75 ta preparat bo'yicha asosiy ma'lumot: ko'rsatma, doza, mumkin bo'lmagan holatlar va vrach bilan suhbat uchun dalillar. Asl tasdiqlangan yo'riqnomalar asosida.



Har bir guruh o'z rangiga ega — sahifa chetidagi rangli belgi bo'yicha kerakli bo'limni tez toping.

Qanday foydalanish

1. **Rangli "Qisqacha" bloki** — doza va asosiy cheklovning qisqa xulosasi (pastdagi bo'limlardan olingan). Avval shuni yodlang.
2. **Ko'rsatmalar va dozalash** — vrach eng ko'p so'raydigan qism.
3. **Mumkin emas** (qizil blok) — imtihonda albatta so'raladi.
4. **Vrach so'rasa** — raqobatchidan farq va afzalliklar (СПВ va pasportlardan).
5. **Sariq punktir blok "Kompaniya materiali (PM)"** — kalit xabar va СПВ. Bu yo'riqnoma emas, reklama materiali; imtihonda yo'riqnoma bo'yicha javob bering.
6. **O'zingizni tekshiring** — javobni yopib, o'zingiz ayting.

Manba: O'zbekiston SSV tomonidan tasdiqlangan yo'riqnomalar, kompaniya pasportlari va СПВ fayllari. Ma'lumot tibbiy vakil tayyorgarligi uchun; davolash bo'yicha qaror — vrach zimmasida. Kartochkalar O'zbekistonda tasdiqlangan yo'riqnomalar bilan solishtirib tekshirilgan; Pramisum, Flutisal va Rosemid ODT — asosan kompaniya pasporti bo'yicha.

Guruhlar

- Nevrologiya — 14 ta
- Psixiatriya — 3 ta
- Revmatologiya va og'riq — 15 ta
- Ginekologiya — 7 ta
- Urologiya va andrologiya — 3 ta
- Dermatologiya — 9 ta
- Infeksiyalar va parazitlar — 10 ta
- Gastroenterologiya — 7 ta
- Pulmonologiya, LOR va allergiya — 7 ta

Mundarija

Nevrologiya
Zoresan, Lanistor, Logufen, Oksapin, Mezakar, Zardeks, Konfundus, Pramisum, Rekol, Servoneks, Kvanil, Neyrokobal, Vertineks, Mezakar SR

Psixiatriya
Dezestra, Flutisal, Rosemid ODT

Revmatologiya va og'riq
Forsanek, Larfiks, Diklotol, Fanigan, Nimid, Nimid Forte, Nimid gel, Dikloseyf, Dikloseyf Maks gel, Fanigan Fast gel, Panash krem, Serrata, Lefno, Alendra, Forkal Plyus

Ginekologiya
Banbakt, Gayneks / Gayneks Forte, Mistol, Kandigo, Dermazol shamlari, Vidanol, Suprileks

Urologiya va andrologiya
Arstifen, Katariya, Moginin

Dermatologiya
Blemish gel, Baktopik surtma, Baktopik nazal surtma, Dermazol krem 2%, Dermazol shampun 2%, Dermazol Plyus shampun, Fusis gel 0,5%, Remov loson 4%, Volvit

Infeksiyalar va parazitlar
Ziomitsin, Taygeron, Laen, Polimik, Orgil, Fizzi, Fusis, Eszol, Albela, Pirantel

Gastroenterologiya
Zolopent, Domrid, Loflatil, Ukrliv, Sogelen, Ezetum 10000, Flyut Astezin

Pulmonologiya, LOR va allergiya
Montular / Montular Kids, Mukeks, L-Set, Gripgo, Gripgo Xotmiks, Askozin Maks, Askotsin

Ilovalar
Ilmiy maqolalar qisqacha, atamalar lug'ati

Nevrologiya

14 ta preparat

Zoresan
Lanistor
Logufen
Oksapin
Mezakar
Zardeks
Konfundus
Pramisum
Rekol
Servoneks
Kvanil
Neyrokobal
Vertineks
Mezakar SR

Nevrologiya

Zoresan

Zonisamid

Qattiq jelatin kapsula 25 / 50 / 100 mg, №30 (3×10)

Tutqanoqqa qarshi (N03AX15). Na- va T-tipli Ca-kanallarni bloklaydi



QISQACHA · **Monoterapiya: 100 mg/sut dan → 300 mg/sut, kuniga 1 marta. Sulfonamid allergiyasida mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Epilepsiya: yangi tashxislangan kattalarda parsial tutqanoqlar (ikkilamchi generalizatsiyali/siz) — monoterapiya
- Parsial tutqanoqlar — qo'shimcha terapiya: kattalar va 6 yoshdan bolalar
- Parkinson kasalligining harakat simptomlari, levodopaga qo'shimcha (off-label, pasport bo'yicha)

Dozalash

- Monoterapiya (kattalar): 100 mg ×1 → har 2 haftada +100 mg; qo'llab-quvvatlovchi 300 mg/sut, maks. 500 mg
- Qo'shimcha, CYP3A4 induktorlari bilan (karbamazepin va b.): 1-hafta 50 mg/sut (2 ga), 2-hafta 100 mg, keyin har hafta +100 mg → 300–500 mg/sut
- Induktorlarsiz yoki buyrak/jigar buzilishida: titrlash har 2 haftada → 300–500 mg/sut
- Bolalar 6 yoshdan (≥20 kg): 1 mg/kg/sut dan, har hafta +1 mg/kg → 6–8 mg/kg/sut (maks. 500 mg)
- Kuniga 1 marta (T½ ≈ 60 soat), ovqatdan qat'i nazar

Mumkin emas

Zonisamid, yordamchi moddalar yoki SULFONAMIDLARGA o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, bosh aylanishi, anoreksiya, vazn kamayishi, xotira buzilishi, buyrak toshi, metabolik atsidoz, depressiya; bolalarda terlash kamayishi va qizib ketish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Biokiraolishligi ~100%, ovqatga bog'liq emas; kuniga 1 marta — qulay
- ILAE (2013): fokal tutqanoqlar monoterapiyasida A darajali dalil
- Kombinatsiya: Mezakar, Oksapin, Logufen, Lanistor bilan (boshlang'ich 50 mg 2 ga bo'lib); Parkinsonda Konfundus + Zoresan 25 mg

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Zoresan — epilepsiyali bemorlar uchun umid uchquni»

- Ko'p komponentli ta'sir mexanizmi; neyroprotektor xossalar
- Parkinsonda levodopaga qo'shimcha: "o'chib qolish" davrini qisqartiradi

O'zingizni tekshiring

Zoresan kimga mumkin emas?

Zonisamid va sulfonamidlarga o'ta sezuvchanlikda.

Zoresan ichayotgan bolaga nimani aytish kerak?

Issiqda qizib ketmaslik, og'ir jismoniy yuklamadan saqlanish, ko'p suv ichish; topiramat/atsetazolamid va antixolinergiklar bilan birga bermaslik.

Nevrologiya

Lanistor

Lamotridjin

Tabletka 25 / 50 / 100 mg

Tutqanoqqa qarshi + normotimik (N03AX09)



QISQACHA · **Doza sekin oshiriladi; valproat bilan boshlang'ich 12,5 mg/sut. Toshma chiqsa — darhol to'xtatiladi.**

Ko'rsatmalar

- Epilepsiya (kattalar va 13 yoshdan): parsial va generalizatsiyalangan, shu jumladan tonik-klonik tutqanoqlar — mono yoki qo'shimcha
- Lennoks-Gasto sindromi — qo'shimcha terapiya
- Bipolyar buzilish (18 yoshdan): asosan depressiv epizodlar profilaktikasi

Dozalash

- Monoterapiya: 1–2 hafta 25 mg ×1 → 3–4 hafta 50 mg ×1 → har 1–2 haftada +50–100 mg; qo'llab-quvvatlovchi 100–200 mg/sut
- Valproat bilan: 1–2 hafta 12,5 mg (25 mg kunora) → 3–4 hafta 25 mg → 100–200 mg/sut
- Induktorlar bilan (karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, rifampitsin): 1–2 hafta 50 mg → 3–4 hafta 100 mg (2 ga) → 200–400 mg/sut
- Tabletka chaynamay yutiladi; 12 yoshgacha bu shakl tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

Lamotridjinga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

TOSHMA (kam hollarda SJS/TEN), bosh og'riq, bosh aylanishi, diplopiya, ataksiya, uyquchanlik, ko'ngil aynishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Glyukuronizatsiya orqali, CYP450 emas; o'z metabolizmini induksiya qilmaydi
- Homiladorlikda nisbatan xavfsiz: 8700+ ayolda I trimestrda nuqson xavfi sezilarli oshmagan; valproat kabi nerv nayi nuqsoni bermaydi
- Sedatsiya kam, kognitiv funksiyani yaxshilaydi; gepato/kardiotoksik emas — keksalarda tanlov preparati

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Lanistor — qiyinchiliklarni yengishda eng oddiy yo'l!»

- Normotimik: kayfiyatni ko'taradi, BAB profilaktikasida samarali
- Kognitiv funksiyani rag'batlantiradi, sedatsiya yo'q
- Gepato- va kardiotoksik emas — katta va keksa yoshdagi bemorlarda 1-tanlov

⚠ SPV da T½ 29 soat; yo'riqnomada o'rtacha 33 soat.

O'zingizni tekshiring

Lanistor bilan eng xavfli nojo'ya ta'sir va undan qanday saqlanish kerak?
Og'ir teri toshmasi (SJS/TEN). Boshlang'ich doza va titrlash tezligini oshirmaslik; toshma chiqsa darhol to'xtatish.

Valproat qabul qilayotgan bemorda Lanistor qanday boshlanadi?
1–2 hafta 12,5 mg (25 mg kunora), 3–4 hafta 25 mg/sut, qo'llab-quvvatlovchi 100–200 mg/sut.

Nevrologiya

Logufen

Levetiratsetam

Tabletka 250 / 500 mg

Tutqanoqqa qarshi (N03AX14), SV2A oqsiliga bog'lanadi



QISQACHA · **Monoterapiya: 250 mg ×2 dan, 2 haftadan keyin 500 mg ×2. Qo'shimcha terapiya: 1-kundan 500 mg ×2. Doza buyrak funksiyasiga qarab.**

Ko'rsatmalar

- Monoterapiya: 16 yoshdan, yangi tashxislangan parsial tutqanoqlar
- Qo'shimcha: 6 yoshdan parsial tutqanoqlar
- Qo'shimcha: 12 yoshdan yuvenil mioklonik epilepsiyada mioklonik va idiopatik generalizatsiyalangan epilepsiyada tonik-klonik tutqanoqlar

Dozalash

- Monoterapiya: 250 mg ×2 → 2 haftadan keyin 500 mg ×2; har 2 haftada +250 mg ×2; maks. 1500 mg ×2
- Qo'shimcha (≥50 kg): 1-kundan 500 mg ×2; maks. 1500 mg ×2
- Buyrak (KK): 50–79 → 500–1000 mg ×2; 30–49 → 250–750 mg ×2; <30 → 250–500 mg ×2
- To'xtatish asta: har 2–4 haftada 500 mg ×2 ga kamaytirish

Mumkin emas

Levetiratsetam yoki pirrolidon hosilalariga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Nazofaringit, uyquchanlik, bosh og'riq, bosh aylanishi, holsizlik; asabiylik, tajovuzkorlik, depressiya — kuzatish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Jigarda metabolizmlanmaydi, CYP450 bilan ishlamaydi — boshqa dorilar bilan deyarli o'zaro ta'sir yo'q
- Birinchi kundan samarali dozadan boshlash mumkin; chiziqli farmakokinetika
- Kuniga 2 marta; biokiraolishlik ~100%, ovqatga bog'liq emas

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Logufen — to'lqin kuchini nazoratga ol!»

- SV2A ga ta'sir — noyob mexanizm; barcha asosiy epilepsiya shakllarida
- Cmax ~1,3 soatda, biokiraolishlik ~100%, ovqatga bog'liq emas
- Samarali dozadan boshlash mumkin; kuniga 2 marta

⚠ SPV da "titrlash shart emas" deyilgan; yo'riqnomada monoterapiya 250 mg ×2 dan boshlanadi — imtihonda yo'riqnoma bo'yicha javob bering.

O'zingizni tekshiring

Logufenning asosiy farmakokinetik afzalligi?
Jigarda metabolizmlanmaydi, CYP450 orqali ishlamaydi — o'zaro ta'sir deyarli yo'q; buyrak orqali chiqadi.

Logufen monoterapiyasi qanday boshlanadi?
250 mg kuniga 2 marta, 2 haftadan keyin 500 mg kuniga 2 marta.

Oksapin

Okskarbazepin

Tabletka 300 mg (bo'luvchi chiziqli)

Tutqanoqqa qarshi (N03AF02), karbamazepin hosilasi



QISQACHA · **Boshlang'ich 600 mg/sut (2 ga bo'lib), terapevtik 600–2400 mg/sut. Natriy darajasi nazorat qilinadi.**

Ko'rsatmalar

- Parsial tutqanoqlar (ikkilamchi generalizatsiyali/siz) — kattalar va 6 yoshdan bolalarda mono yoki kombinatsiyada

Dozalash

- Kattalar: 600 mg/sut (8–10 mg/kg) 2 ga bo'lib; har hafta maks. +600 mg; terapevtik 600–2400 mg/sut
- Monoterapiyada 1200 mg/sut samarali; maks. 2400 mg/sut
- Bolalar 6 yoshdan: 8–10 mg/kg/sut 2 ga → ~30 mg/kg/sut, maks. 46 mg/kg/sut
- Buyrak KK<30: boshlang'ich 300 mg/sut; kuniga 2 marta, ovqatdan qat'i nazar

Mumkin emas

Okskarbazepin yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, bosh og'riq, bosh aylanishi, diplopiya, ko'ngil aynishi, qusish, charchoq; GIPONATRIEMIYA (natriyni nazorat)

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Karbamazepin samarasi, lekin xavfsizroq; chiziqli farmakokinetika — samarali dozadan boshlash mumkin
- Karbamazepindan 1 kunda o'tkazish mumkin; mikrosomal fermentlarni deyarli induksiya qilmaydi
- Start monoterapiyada A darajali dalil; 6 yoshdan; KOK samarasini kamaytiradi (etinilestradiol ~50% gacha) — boshqa kontratsepsiya kerak

---

O'zingizni tekshiring

Oksapin karbamazepindan nimasi bilan farq qiladi?
Xavfsizlik profili yaxshiroq, chiziqli farmakokinetika, fermentlarni deyarli induksiya qilmaydi; karbamazepindan 1 kunda o'tkazish mumkin.

Oksapinning terapevtik doza oralig'i (kattalar)?
600–2400 mg/sut, 2 ga bo'lib; monoterapiyada odatda 1200 mg/sut.

Mezakar

Karbamazepin

Tabletka 200 mg

Tutqanoqqa qarshi, normotimik (N03AF01)



QISQACHA · **Epilepsiya, uch shoxli nerv nevralgiyasi, maniakal-depressiv profilaktika. Qon tahlili va natriy nazorati.**

Ko'rsatmalar

- Epilepsiya: parsial (ikkilamchi generalizatsiyali) va generalizatsiyalangan tonik-klonik tutqanoqlar
- Uch shoxli nerv nevralgiyasi
- Litiyga javob bermaydigan maniakal-depressiv psixoz profilaktikasi

Dozalash

- Epilepsiya, kattalar: 100–200 mg 1–2 marta dan → odatda 800–1200 mg/sut, ba'zan 1600–2000 mg; kuniga 2–3 marta, ovqat bilan yoki keyin
- Bolalar: 5–10 yosh 400–600 mg/sut; 10–15 yosh 600–1000 mg/sut; >15 yosh 800–1200 mg/sut
- Nevralgiya: 200–400 mg/sut dan, odatda 200 mg 3–4 marta; maks. 1200 mg; keksalar 100 mg ×2 dan
- Maniakal-depressiv profilaktika: 400–1600 mg/sut, odatda 400–600 mg

Mumkin emas

O'ta sezuvchanlik (shu jumladan TTsA ga), AV blokada, suyak iligi depressiyasi anamnezi, jigar porfiriyasi, MAO ingibitorlari bilan

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh aylanishi, ataksiya, uyquchanlik, diplopiya, ko'ngil aynishi, toshma, leykopeniya, giponatriemiya; kam — agranulotsitoz, SJS

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Fokal epilepsiyaning "oltin standarti"; Finlepsin/Tegretolga ekvivalent; GMP WHO
- Nevrolog, psixiatr, narkolog, neyroxirurg uchun: nevropatik og'riq, normotimik, abstinensiyada
- Kuchli CYP3A4 induktori: KOK, varfarin va boshqa dorilar samarasini kamaytiradi

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Mezakar — impulslar ustidan to'liq nazorat! Fokal epilepsiyada tanlov preparati»

- Yaxshi o'rganilgan molekula, sifatli generik, arzon
- Qadoqda 50 tabletka — uzoqqa yetadi
- Neyropatik og'riqda patogenetik ta'sir

O'zingizni tekshiring

Uch shoxli nerv nevralgiyasida Mezakar dozasi?
200–400 mg/sut dan boshlab, og'riq ketguncha (odatda 200 mg 3–4 marta), maks. 1200 mg/sut.

Mezakar qaysi hollarda mumkin emas?
AV blokada, suyak iligi depressiyasi anamnezi, jigar porfiriyasi, MAO ingibitorlari bilan birga, o'ta sezuvchanlik.

Zardeks



Gabapentin

Kapsula 300 mg

Tutqanoqqa qarshi, nevropatik og'riqqa qarshi (N03AX12)

QISQACHA · **Titrlash: 1-kun 300 mg ×1, 2-kun ×2, 3-kun ×3; maks. 3600 mg/sut. Doza buyrak funksiyasiga qarab.**

Ko'rsatmalar

- Epilepsiya: parsial tutqanoqlar (6 yoshdan qo'shimcha, 12 yoshdan monoterapiya)
- Kattalarda periferik nevropatik og'riq (diabetik neyropatiya, postgerpetik nevralgiya)

Dozalash

- Titrlash: 1-kun 300 mg ×1, 2-kun 300 mg ×2, 3-kun 300 mg ×3 (900 mg/sut)
- Keyin har 2–3 kunda +300 mg; maks. 3600 mg/sut, 3 ga bo'lib (oraliq 12 soatdan ko'p emas)
- Bolalar 6+: 10–15 mg/kg/sut dan → 25–35 mg/kg/sut
- Buyrak KK: 50–79 → 600–1800; 30–49 → 300–900; 15–29 → 150–600 mg/sut
- To'xtatish kamida 1 hafta davomida asta

Mumkin emas

> Gabapentinga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, bosh aylanishi, ataksiya, holsizlik, isitma, ko'ngil aynishi, diareya; kam — o'tkir pankreatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Nevropatik og'riqda va epilepsiyada — ikki yo'nalish
- Ovqat bilan yoki ovqatsiz, yetarli suv bilan
- Opioidlar bilan nafas depressiyasi xavfi — ehtiyot

O'zingizni tekshiring

Zardeks titrlashining birinchi 3 kuni?

1-kun 300 mg ×1, 2-kun 300 mg ×2, 3-kun 300 mg ×3.

Zardeks dozasi nimaga qarab tuzatiladi?

Buyrak funksiyasiga (kreatinin klirensi) qarab.

Konfundus

Levodopa 250 mg + Karbidopa 25 mg

Tabletka, №100 (bo'luvchi chiziqli)

Parkinsonga qarshi, dofaminergik (N04BA02)



QISQACHA · **Boshlang'ich ½ tab kuniga 1–2 marta, asta oshiriladi; maks. 8 tab/sut. Birdan to'xtatilmaydi.**

Ko'rsatmalar

- Parkinson kasalligi va parkinsonizm sindromi

Dozalash

- Levodopa olmaganlar: ½ tab kuniga 1–2 marta ovqatdan keyin; har kuni yoki kunora +½ tab
- To'liq samara bir hafta yoki undan ko'proqda
- Levodopa olganlar: levodopani kamida 12 soat (sekin bo'shatiluvchi — 24 soat) oldin to'xtatish; Konfundus dozasi avvalgi levodopa dozasining ~20%
- >1500 mg levodopa olganlar: 1 tab kuniga 3–4 marta; maks. 8 tab/sut (karbidopa 200 mg + levodopa 2 g)
- 18 yoshgacha tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

> Noselektiv MAO ingibitorlari (2 hafta oldin to'xtatish), yopiq burchakli glaukoma, shubhali teri o'smalari yoki melanoma anamnezi, og'ir psixoz, o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Diskineziya, ko'ngil aynishi, ortostatik gipotenziya, gallyutsinatsiya, to'satdan uxlab qolish, impuls nazorati buzilishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- 17 yillik klinik tajriba; rivojlangan bosqichda monoterapiya
- "On-off" va doza tugashi fenomenida holatni yaxshilaydi
- ½ tab ×2 da bitta upakovka ~3 oyga yetadi — iqtisodiy; Pramisum, Zoresan, Rekol, Neyrokobal bilan kombinatsiya

---

O'zingizni tekshiring

Konfundus bilan qaysi MAO ingibitorini birga berish mumkin?

Selektiv MAO-B ingibitori selegilinni tavsiya dozada; noselektiv MAO ingibitorlari mumkin emas.

Konfundus upakovkasi nega iqtisodiy?

100 tabletka: ½ tab kuniga 2 marta qabulda ~3 oyga yetadi.

Pramisum



Pramipeksol

Tabletka 0,25 mg va 1,0 mg, №30

Dofamin retseptorlari agonisti (N04BC05)

QISQACHA · **Parkinson va bezovta oyoqlar sindromi. Doza asta titrlanadi; uyquchanlik va impuls nazorati buzilishi haqida ogohlantiriladi.**

Ko'rsatmalar

- Idiopatik Parkinson kasalligi: monoterapiya yoki levodopa bilan ("on-off" fluktuatsiyalarda)
- O'rta va og'ir idiopatik bezovta oyoqlar sindromi (dozasi 0,75 mg gacha)

Dozalash

- Parkinson: sutkalik doza 3 ga bo'linadi; 0,375 mg/sut dan, har 5–7 kunda oshirish
- Keyin har hafta +0,75 mg; maks. 4,5 mg/sut; ≥1,5 mg da uyquchanlik ko'payadi
- Bezovta oyoqlar: 0,125 mg uxlashdan 2–3 soat oldin; har 4–7 kunda oshirish, maks. 0,75 mg
- To'xtatish asta: 0,75 mg/sut dan kamaytirib (birdan to'xtatish — neyroleptik malign sindrom)

Mumkin emas

> Pramipeksol yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, diskineziya, gipotenziya, uyquchanlik, to'satdan uxlab qolish, gallyutsinatsiya, impuls nazorati buzilishi (qimor, xarid)

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Barcha bosqichlarda samarali; erta bosqichda levodopa samarasiga yaqin
- Levodopaga o'tishni kechiktiradi; levodopa bilan birga bo'lsa levodopa dozasini kamaytirish mumkin
- Kombinatsiya: Konfundus + Pramisum (+ Rekol demensiyada, + Neyrokobal gomotsisteinda)

O'zingizni tekshiring

Bezovta oyoqlar sindromida Pramisum qanday qabul qilinadi?

0,125 mg uxlashdan 2–3 soat oldin, har 4–7 kunda oshirib, maks. 0,75 mg/sut.

Pramisum bilan bemorni nimadan ogohlantirish kerak?

To'satdan uxlab qolish (haydash xavfli) va impuls nazorati buzilishi (qimor, xarid, giperseksuallik).

Nevrologiya

Rekol

Memantin

Tabletka 10 mg (bo'luvchi chiziqli); qadoqda 20 mg shakli ham bor

Demensiyaga qarshi, NMDA retseptor antagonisti (N06DX01)



QISQACHA · Titrlash 5 → 10 → 15 → 20 mg (har hafta), kuniga 1 marta. Amantadin, ketamin bilan birga emas.

Ko'rsatmalar

- O'rta va og'ir darajali Altsgeymer demensiyasi

Dozalash

- Titrlash: 1-hafta 5 mg → 2-hafta 10 mg → 3-hafta 15 mg → 4-haftadan 20 mg/sut
- KUNIGA 1 MARTA, har kuni bir vaqtda; samara va o'zlashtirish 3 oy ichida baholanadi
- Buyrak KK 30–49: 10 mg (yaxshi o'zlashtirilsa 20 mg); KK 5–29: 10 mg/sut
- Og'ir jigar yetishmovchiligida tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

Memantin yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, bosh aylanishi, muvozanat buzilishi, AQB oshishi, qabziyat, bosh og'riq; kam — chalkashlik, gallyutsinatsiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Patogenetik davo: ortiqcha glutamatdan neyronlarni himoya qiladi; erta tayinlash progressiyani sekinlatadi
- Donepezil (Servoneks) bilan kombinatsiyasi FDA tomonidan tasdiqlangan
- Kuniga 1 marta — parvarish qulay; O'zbekistondagi eng arzon memantin

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Rekol — aql-idrokni saqlab qolamiz! / intellekt aylanishini saqla!»

- Demensiyaning patogenetik davosi (NMDA blokadasi), FDA tomonidan ma'qullangan
- Parvarishlovchi kuniga 1 marta beradi — qulay
- Narxi arzon

O'zingizni tekshiring

Rekol qaysi dorilar bilan birga berilmaydi?

Boshqa NMDA antagonistlari: amantadin, ketamin, dekstrometorfan (psixoz xavfi).

Rekolning qo'llab-quvvatlovchi dozasi?

20 mg kuniga 1 marta (4-haftadan).

Servoneks

Donepezil

Tabletka 5 mg / 10 mg

Atsetilxolinesteraza ingibitori (N06DA02)



QISQACHA · 5 mg kechqurun, kamida 1 oydan keyin 10 mg. Bradikardiya xavfi.

Ko'rsatmalar

- Yengil va o'rtacha og'ir Altsgeymer demensiyasi (simptomatik davo); SPV: aralash va tomir demensiyasida ham samarali

Dozalash

- 5 mg kuniga 1 marta KECHQURUN, uxlashdan oldin
- Kamida 1 oydan keyin 10 mg gacha; maks. 10 mg/sut
- Buyrak — tuzatish shart emas; 18 yoshgacha tavsiya etilmaydi
- Davolashni demensiya bo'yicha tajribali vrach boshlaydi; parvarishlovchi bo'lishi kerak

Mumkin emas

Donepezil yoki piperidin hosilalariga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Diareya, ko'ngil aynishi, bosh og'riq, uyqusizlik, mushak tortishishi, BRADIKARDIYA; kam — SA/AV blokada, GI qon ketish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- 1/3 bemorda yaxshilanish, 2/3 da stabilizatsiya; parvarish yukini va neyroleptik ehtiyojini kamaytiradi
- T½ ≈ 70 soat — kuniga 1 marta
- Rekol bilan kombinatsiya (tez progressiyalanuvchi demensiyada)

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Servoneks — intellekt involyutsiyasini to'xtat!»

- Altsgeymer va tomir demensiyasida samarali — aralash shakllarda dorilar soni kamayadi
- Parvarish muassasasiga yotqizishni kechiktiradi, neyroleptik ehtiyojini kamaytiradi
- Kuniga 1 marta

O'zingizni tekshiring

Servoneks qachon qabul qilinadi?

Kechqurun, uxlashdan oldin, kuniga 1 marta.

Servoneksda yurakka oid asosiy ehtiyot?

Bradikardiya va SA/AV blokada xavfi — sinus tugun zaifligi bo'lsa ehtiyot.

Kvanil

Sitikolin

Tabletka 500 mg; in'eksiya 500 mg/4 ml va 1000 mg/4 ml

Nootrop, neyroprotektor (N06BX06)



QISQACHA · **500–2000 mg/sut. O'tkir bosh suyagi ichi qon quyilishida maks. 1000 mg/sut.**

Ko'rsatmalar

- Insultning o'tkir bosqichi, asoratlari va oqibatlari
- Bosh miya jarohati va uning nevrologik oqibatlari
- Degenerativ va tomir serebral patologiyasida kognitiv, sensor, motor va xulq buzilishlari

Dozalash

- Tabletka: 500–2000 mg/sut (1–4 tab)
- In'eksiya: 500–2000 mg/sut v/i yoki m/i; v/i sekin 3–5 daqiqa yoki tomchilab 40–60 tomchi/daq
- O'tkir bosh suyagi ichi qon quyilishida 1000 mg/sutdan oshmasin (30 tomchi/daq)
- Keksalarga tuzatish shart emas; keyin peroral shaklga o'tish mumkin

Mumkin emas

O'ta sezuvchanlik; parasimpatik nerv tizimi tonusi yuqoriligi

Nojo'ya ta'sirlar

Juda kam (<1/10 000): bosh og'riq, uyqusizlik, qo'zg'aluvchanlik, AQB o'zgarishi, ko'ngil aynishi, toshma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Neyroprotektor va apoptoz ingibitori: o'tkir davrda ham, reabilitatsiyada ham samarali — sxemani keskin o'zgartirish shart emas
- Yuqori dozada ham xavfsizligi platseboga yaqin
- Substansiya Yaponiyada ishlab chiqarilgan; narxi qulay

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Kvanil — neyroproteksiya va tiklanish!»

- Ishemik insultning dastlabki 24 soatida peroral sitikolin 3 oy ichida to'liq tiklanish ehtimolini oshiradi
- O'tkir davrda ham, reabilitatsiyada ham samarali — sxemani o'zgartirish shart emas
- In'eksiya va tabletka — bosqichli davo; substansiya Yaponiyada

O'zingizni tekshiring

Kvanil levodopa bilan qanday ta'sirlashadi?
Levodopa ta'sirini kuchaytiradi; meklofenoksat bilan birga berilmaydi.

O'tkir bosh suyagi ichi qon quyilishida Kvanilning maksimal dozasi?
1000 mg/sut, tomchilab 30 tomchi/daqiqa.

Neyrokobal

Metilkobalamin

Tabletka 500 mkg

Vitamin B12 ning faol koenzim shakli (B03BA05)



QISQACHA · Metilkobalamin (faol B12) 500 mkg kuniga 3 marta = 1500 mkg/sut.

Ko'rsatmalar

- Periferik neyropatiya
- Diabetik neyropatiya
- Alkogol neyropatiyasi
- Dori bilan bog'liq neyropatiya
- Demensiya (qo'shimcha)

Dozalash

- Kattalar: 1 tabletka kuniga 3 marta (1500 mkg/sut)
- Bir oy samara bo'lmasa, uzoq davom ettirmaslik

Mumkin emas

Komponentlarga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Kam: toshma, anoreksiya, ko'ngil aynishi, diareya, bosh og'riq

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Siankobalaminga nisbatan nerv to'qimasiga yaxshi kiradi — aksonal regeneratsiya va mielinizatsiya
- Gomotsisteinni metioninga aylantiradi — Parkinsonda giperhomotsisteinemiyada (Konfundus + Pramisum + Neyrokobal)
- So'rilishini kamaytiradi: omeprazol, H2-blokatorlar, kolxitsin, neomitsin

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Neyrokobal — B12 ning faol shakli: nerv uchun»

- 500 mkg × 3 = 1500 mkg/sut — neyropatiyada samarali doza; B-kompleks vitaminlarda B12 kamroq
- O'zbekistondagi yagona metilkobalamin (kompaniya ma'lumoti)
- Narxi qulay — to'liq kursga yetadi

⚠ SPV dagi "FDA tavsiya qilgan yagona neyrovitamin" da'vosi kompaniya materialida; rasmiy manbada tasdig'ini ko'rmadim — vrachga manbasiz aytmang.

O'zingizni tekshiring

Neyrokobal oddiy B12 dan nimasi bilan farq qiladi?

Faol koenzim shakli (metilkobalamin): nerv to'qimasiga yaxshi kiradi, faollashuv talab qilmaydi.

Neyrokobal sutkalik dozasi?

500 mkg kuniga 3 marta = 1500 mkg/sut.

Vertineks

Proxlorperazin

Tabletka 5 mg

Fenotiazin neyroleptik, qusishga qarshi (N05AB04)



QISQACHA · Menyer/vertigo: 5 mg ×3. Qusish: 20 mg, kerak bo'lsa 2 soatdan keyin 10 mg.

Ko'rsatmalar

- Menyer sindromi, labirintit va boshqa sabablardan bosh aylanishi
- Har qanday sababli ko'ngil aynishi va qusish (migren bilan bog'liq ham)
- Shizofreniya, o'tkir mania, xavotirni qisqa muddat boshqarish — yordamchi

Dozalash

- Ko'ngil aynishi profilaktikasi: 5–10 mg kuniga 2–3 marta
- Ko'ngil aynishi/qusish davosi: 20 mg bir marta, kerak bo'lsa 2 soatdan keyin 10 mg
- Vertigo/Menyer: 5 mg ×3, kerak bo'lsa 30 mg/sut gacha; keyin 5–10 mg/sut gacha kamaytirish
- Xavotir: 15–20 mg/sut, maks. 40 mg; 12 yoshgacha tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

> Proxlorperazin yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, og'iz qurishi, o'tkir distoniya (yoshlarda), akatiziya, parkinsonizm, giperprolaktinemiya, gipotenziya, QT uzayishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Vestibulyar bosh aylanishi va qusishni bir dori bilan yopadi
- Gipotenziyada adrenalin ishlatilmaydi
- Keksalarga past doza

O'zingizni tekshiring

Menyer sindromida Vertineks dozasi?

5 mg kuniga 3 marta, kerak bo'lsa 30 mg/sut gacha; keyin 5–10 mg/sut gacha kamaytiriladi.

Vertineksning yoshlarda tez-tez uchraydigan nojo'ya ta'siri?

O'tkir distoniya (okulogir kriz) — odatda davolashning dastlabki 4 kunida.

Mezakar SR

Karbamazepin 400 mg (ta'sir uzaytirilgan)

Tabletka 400 mg ("C400", bo'luvchi chiziqli), №50 (5×10)

Tutqanoqqa qarshi, neyrotrop va psixotrop (N03AF01)



QISQACHA · 400 mg, kuniga 2 marta. 6 yoshgacha tavsiya etilmaydi; absans va mioklonik tutqanoqlarda samarasiz.

Ko'rsatmalar

- Epilepsiya: generalizatsiyalangan tonik-klonik va parsial tutqanoqlar (yangi tashxis va nazorat qilinmagan holatlar)
- Uch shoxli nerv nevralgiyasi
- Litiyga javob bermaydigan maniakal-depressiv psixoz profilaktikasi

Dozalash

- Sutkalik doza 2 ga bo'linadi (kuniga 2 marta); butun yoki yarim tabletka, chaynamay
- Kattalar: 200–400 mg dan → odatda 800–1200 mg/sut; ba'zan 1600–2000 mg
- Bolalar 10–20 mg/kg: 6–10 yosh 400–600 mg; 10–15 yosh 600–1000 mg; >15 yosh 800–1200 mg; 6 yoshgacha tavsiya etilmaydi
- Nevralgiya: 200–400 mg dan, odatda 600–800 mg, maks. 1200 mg; keksalar 200 mg dan
- Oddiy Mezakardan o'tishda sutkalik doza o'zgarmaydi

Mumkin emas

Mezakar bilan bir xil (o'ta sezuvchanlik, AV blokada, suyak iligi depressiyasi anamnezi, jigar porfiriyasi, MAO ingibitorlari bilan)

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh aylanishi, ataksiya, uyquchanlik, diplopiya, ko'ngil aynishi, qusish, allergik toshma; giponatriemiya; kam — SJS

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Oddiy Mezakardan farqi: kuniga 2 marta — qonda konsentratsiya barqarorroq
- Absans va mioklonik tutqanoqlarda samarasiz (kuchaytirishi mumkin)
- Xitoy va tay millatiga mansub bemorlarda HLA-B*1502 skrining (SJS xavfi)

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Mezakar — impulslar ustidan to'liq nazorat!»

- Uzaytirilgan shakl: kuniga 2 marta qabul

O'zingizni tekshiring

Mezakar SR ning oddiy Mezakardan afzalligi?

Ta'sir uzaytirilgan: sutkalik doza 2 ga bo'linadi, konsentratsiya barqarorroq.

Mezakar SR qaysi tutqanoqlarda samarasiz?

Absans (petit mal) va mioklonik tutqanoqlarda.

Psixiatriya

3 ta preparat

Dezestra

Flutisal

Rosemid ODT

Dezestra



Essitalopram

Tabletka 10 mg / 20 mg, №28 / №56

Antidepressant, SSRI (N06AB10)

QISQACHA · **10 mg kuniga 1 marta, maks. 20 mg; keksalarga 5–10 mg. MAO ingibitorlari va QT uzaytiruvchilar bilan emas.**

Ko'rsatmalar

- Katta depressiv epizodlar
- Agorafobiyali/agorafobiyasiz vahima buzilishi
- Ijtimoiy xavotirli buzilish (ijtimoiy fobiya)
- Tarqalgan (generalizatsiyalangan) xavotirli buzilish
- Obsessiv-kompulsiv buzilish

Dozalash

- Kuniga 1 marta, ovqatdan qat'i nazar; maks. 20 mg/sut
- Depressiya, TXB, OKB, ijtimoiy xavotir: 10 mg → kerak bo'lsa 20 mg
- Vahima buzilishi: 1-hafta 5 mg, keyin 10 mg (maks. 20 mg)
- Keksalar >65, jigar buzilishi, CYP2C19 sust metabolizatorlar: 5 mg → maks. 10 mg
- Depressiyada simptom ketgach kamida 6 oy; to'xtatish 1–2 hafta davomida asta

Mumkin emas

MAO ingibitorlari bilan (to'xtatgandan 14 kun keyin), moklobemid, LINEZOLID; QT uzayishi yoki tug'ma uzun QT; QT uzaytiruvchi dorilar bilan; o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, bosh og'riq, uyqusizlik/uyquchanlik, terlash, libido kamayishi, eyakulyatsiya buzilishi; kam — serotonin sindromi, giponatriemiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Javob 2–4 haftada; vahimada maksimal samara ~3 oyda
- Tramadol, triptanlar bilan serotonin sindromi; antikoagulyant/NYaQP bilan qon ketish xavfi
- 18 yoshgacha qo'llanmaydi; emizish tavsiya etilmaydi

O'zingizni tekshiring

Vahima buzilishida Dezestra qanday boshlanadi?

Birinchi hafta 5 mg, keyin 10 mg/sut; kerak bo'lsa 20 mg gacha.

Dezestra qaysi antibiotik bilan mumkin emas?

Linezolid (Laen) — qaytariluvchan noselektiv MAO ingibitori, serotonin sindromi xavfi.

Flutisal

Fluoksetin

Kapsula 20 mg, №30

Antidepressant, SSRI (N06AB03)



QISQACHA · **Depressiya va OKB: 20 mg/sut. Bulimik nevroz: 60 mg/sut.**

Ko'rsatmalar

- Katta depressiv epizodlar
- Obsessiv-kompulsiv buzilish
- Bulimik nevroz (psixoterapiyaga qo'shimcha)

Dozalash

- Depressiya: 20 mg/sut; 3–4 haftada qayta baholash; kamida 6 oy davolash
- OKB: 20 mg/sut, maks. 60 mg; 10 haftada yaxshilanmasa qayta ko'rib chiqish
- Bulimiya: 60 mg/sut
- Bitta yoki bo'lib qabul, ovqatdan qat'i nazar

Mumkin emas

> O'ta sezuvchanlik; noselektiv qaytarilmas MAO ingibitorlari bilan; yurak yetishmovchiligida qo'llanadigan metoprolol bilan

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, ko'ngil aynishi, uyqusizlik, charchoq, diareya; xavotir, libido kamayishi, terlash; kam — giponatriemiya, suitsidal fikrlar

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Nojo'ya ta'sirlar odatda davolash davomida kamayadi
- Oilaviy vrach, nevrolog, psixiatr uchun
- Uzoq T½ — bekor qilish sindromi nisbatan kam

O'zingizni tekshiring

Bulimik nevrozda Flutisal dozasi?

60 mg/sut.

Flutisal qaysi yurak dorisi bilan mumkin emas?

Yurak yetishmovchiligida qo'llanadigan metoprolol bilan.

Rosemid ODT



Risperidon

Og'izda dispergirlanuvchi tabletka 2 mg / 4 mg, №30

Antipsixotik (N05AX08)

QISQACHA · **Shizofreniya: 2 mg, keyin 4 mg/sut. Demensiyadagi agressiya: 0,5 mg ×2, 6 haftadan ortiq emas.**

Ko'rsatmalar

- Shizofreniya
- Bipolyar buzilishda maniakal epizodlar
- O'rta va og'ir Altsgeymer demensiyasida turg'un agressiya — 6 haftagacha
- 5 yoshdan bolalar va o'smirlarda aqliy rivojlanishi past bo'lganda xulq buzilishidagi agressiya — 6 haftagacha

Dozalash

- Shizofreniya: 2 mg/sut, 2-kun 4 mg
- Mania: 2 mg kuniga 1 marta; har ≥24 soatda 1 mg ga tuzatish
- Demensiyadagi agressiya: 0,25 mg ×2 → optimal 0,5 mg ×2 (maks. 1 mg ×2), 6 haftadan ortiq emas
- Xulq buzilishi (≥50 kg): 0,5 mg ×1 → optimal 1 mg ×1

Mumkin emas

> Risperidon yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Parkinsonizm, uyquchanlik, bosh og'riq, uyqusizlik (≥10%); akatiziya (dozaga bog'liq), giperprolaktinemiya, vazn ortishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- ODT shakli: suvsiz og'izda eriydi — yutishga qiynaladigan va qabulni yashiradigan bemorlarga qulay
- Nevrolog va psixiatr uchun ko'rsatmalari bor
- Demensiya agressiyasida qisqa kurs (≤6 hafta)

O'zingizni tekshiring

Altsgeymer demensiyasidagi agressiyada Rosemid dozasi?

0,25 mg ×2 dan, optimal 0,5 mg ×2, maks. 1 mg ×2; 6 haftadan oshmaydi.

ODT shaklining afzalligi?

Og'izda suvsiz eriydi — yutish qiyin yoki qabulni yashiradigan bemorlarga qulay.

Revmatologiya va og'riq

15 ta preparat

Forsanek
Larfiks
Diklotol
Fanigan
Nimid
Nimid Forte
Nimid gel
Dikloseyf
Dikloseyf Maks gel
Fanigan Fast gel
Panash krem
Serrata
Lefno
Alendra
Forkal Plyus

Forsanek

Etorikoksib

Tabletka 60 / 90 / 120 mg, №7 / №28

Selektiv COX-2 ingibitori, koksib (M01AH05)



QISQACHA · **Kuniga 1 marta: OA 30 mg, RA va AS 60 mg, tish operatsiyasidan keyin 90 mg (3 kun), podagra 120 mg (8 kun).**

Ko'rsatmalar

- Osteoartrit, revmatoid artrit, ankilozlovchi spondilit simptomlari (kattalar va 16 yoshdan)
- O'tkir podagrik artritda og'riq va yallig'lanish
- Jarrohlik bilan bog'liq o'rtacha og'riqni qisqa muddat davolash

Dozalash

- Kuniga 1 marta, ovqatdan qat'i nazar
- Osteoartrit: 30 mg (maks. 60 mg)
- RA va ankilozlovchi spondilit: 60 mg (maks. 90 mg)
- O'tkir podagra: 120 mg, maks. 8 kun
- Stomatologik operatsiyadan keyingi og'riq: 90 mg, maks. 3 kun
- Jigar: yengil — maks. 60 mg; o'rta — maks. 30 mg; KK<30 — mumkin emas

Mumkin emas

> Faol yara/GI qon ketish; ASK/NYaQP ga allergiya; homiladorlik va laktatsiya; og'ir jigar, KK<30; 16 yoshgacha; yallig'lanishli ichak kasalligi; yurak yetishmovchiligi NYHA II–IV; nazorat qilinmagan AQB >140/90; YuIK, periferik arteriya va serebrovaskulyar kasallik

Nojo'ya ta'sirlar

Qorin og'riq, shish, GIPERTENZIYA, bosh aylanishi, dispepsiya, diareya, ALT/AST oshishi, alveolyar ostit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Me'da prostaglandinlari va trombotsitlarga ta'sir qilmaydi; 90 mg ta'siri ~28 daqiqada boshlanadi
- MEDAL (34 701 bemor): me'da-ichak yuqori bo'limi asoratlari diklofenakdan ~31% kam; jigar sababli bekor qilish 0,3% vs 2,7%
- Trombotik xavf diklofenak bilan bir xil; ASK o'rnini bosmaydi; AQB ni 2 hafta ichida tekshirish

O'zingizni tekshiring

O'tkir podagrada Forsanek dozasi va muddati?
120 mg kuniga 1 marta, ko'pi bilan 8 kun.

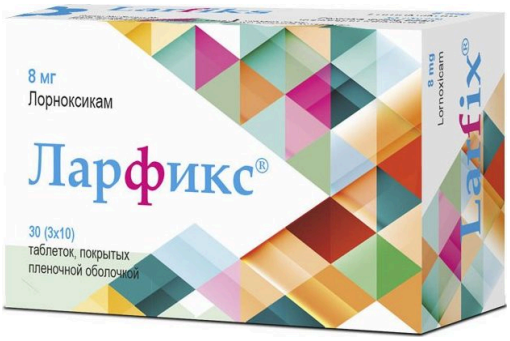
Forsanekni diklofenakdan ajratib turadigan dalil?
MEDAL dasturi: me'da-ichak asoratlari va jigar tufayli bekor qilish diklofenakdan kam, trombotik xavf esa bir xil.

Larfiks

Lornoksikam

Tabletka 8 mg

NYaQP, oksikamlar (M01AC05)



QISQACHA · O'tkir og'riq: 8–16 mg/sut. Revmatoid artrit: 12 mg/sut. Maks. 16 mg/sut.

Ko'rsatmalar

- Yengil va o'rta o'tkir og'riqni qisqa muddat davolash
- Revmatoid artritda og'riq va yallig'lanishni simptomatik yengillatish

Dozalash

- O'tkir og'riq: 8–16 mg/sut, 2–3 ga bo'lib; 1-kun 16 mg, 12 soatdan keyin yana 8 mg mumkin; keyin maks. 16 mg/sut
- Revmatoid artrit: 12 mg/sut 2–3 ga bo'lib; maks. 16 mg/sut
- Yengil-o'rta buyrak/jigar buzilishi: maks. 12 mg/sut
- 18 yoshgacha mumkin emas; yetarli suv bilan

Mumkin emas

ASK/NYaQP ga allergiya; trombotsitopeniya; og'ir yurak, jigar, buyrak yetishmovchiligi; faol/qaytalanuvchi yara, GI yoki serebrovaskulyar qon ketish; homiladorlik III trimestri; 18 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, qorin og'riq, dispepsiya, diareya, qusish, bosh og'riq, bosh aylanishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Kuchli og'riqsizlantiruvchi, qisqa T½
- Varfarin, geparin (spinal gematoma), SSRI, KS bilan qon ketish xavfi
- APF ingibitori, sartan, diuretik samarasini kamaytiradi; litiy, metotreksat darajasini oshiradi

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Larfiks — kuchli va tez og'riqsizlantiruvchi zamonaviy NYaQP»

- 8 mg ×2 — ketorolak, ibuprofen va tramadolning maksimal dozalariga teng (SPV)
- Ta'sir 15–30 daqiqada, maksimum ~1 soatda
- Qisqa T½ — gastropatiya kam; tog'ayga zararsiz
- Buyrak sanchig'ida metamizol va ketorolakdan kuchliroq (SPV)

O'zingizni tekshiring

Larfiksning sutkalik maksimal dozasi?

16 mg/sut (buyrak/jigar buzilishida 12 mg).

Larfiks qaysi yoshdan?

18 yoshdan.

Diklotol

Aseklofenak

Tabletka 100 mg

NYaQP (M01AB16)



QISQACHA · Aseklofenak (diklofenak emas) 100 mg kuniga 2 marta, maks. 200 mg/sut.

Ko'rsatmalar

- Osteoartrit, revmatoid artrit, ankilozlovchi spondilit — og'riq va yallig'lanish
- Tayanch-harakat apparatining boshqa og'riqli kasalliklari (yelka-kurak periartriti, bo'g'imdan tashqari revmatizm)
- Analgetik sifatida: bel og'rig'i, tish og'rig'i, birlamchi dismenoreya

Dozalash

- Kattalar: 100 mg kuniga 2 marta (ertalab va kechqurun); maks. 200 mg/sut
- Yarim stakan suv bilan; ovqat bilan mumkin
- Yengil-o'rta jigar buzilishi: 100 mg/sut; keksalarga tuzatish shart emas

Mumkin emas

Aseklofenak/komponentga sezuvchanlik; faol yoki qaytalanuvchi peptik yara/qon ketish (2+ epizod); ibuprofen, ASK, NYaQP ga allergiya (astma, rinit, angioedema, eshakemi); jigar va buyrak yetishmovchiligi; yurak yetishmovchiligi NYHA II–IV, YuIK, periferik arteriya va serebrovaskulyar kasallik; NYaQP bilan bog'liq qon ketish/perforatsiya anamnezi; qon ketish yoki ivish buzilishi; homiladorlik III trimestri

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh aylanishi, dispepsiya, qorin og'riq, ko'ngil aynishi, diareya, jigar fermentlari oshishi; kam — GI qon ketish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Nomiga qaramay diklofenak EMAS — aseklofenak
- Kuniga 2 marta qulay sxema
- Trombotik xavf diklofenak kabi — yurak-qon tomir xavfida ehtiyot

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Diklotol — artrozli bemorlarni uzoq davolash uchun xondroprotektiv xossali NYaQP»

- Diklofenakka nisbatan me'da-ichak xavfsizligi yaxshiroq — bekor qilish kam
- Tog'ay to'qimasi metabolizmiga ijobiy ta'sir
- Narxi qulay

O'zingizni tekshiring

Diklotolning ta'sir etuvchi moddasi?
Aseklofenak 100 mg (diklofenak emas).

Diklotol dozalash sxemasi?
100 mg kuniga 2 marta, maks. 200 mg/sut.

Fanigan

Paratsetamol 500 mg + Diklofenak natriy 50 mg

Tabletka

NYaQP kombinatsiyasi (M01AB55)



QISQACHA · 1 tab kuniga 2–3 marta ovqatdan keyin, maks. 3 tab/sut, 5–7 kungacha. 14 yoshdan.

Ko'rsatmalar

- O'tkir og'riq: bel, mushak, bosh, tish og'rig'i
- RA, ankilozlovchi spondilit, osteoartroz, o'tkir podagra xurujlari
- Birlamchi dismenoreya, adneksit; faringotonzillit, otit
- Jarohat va operatsiyadan keyingi og'riq

Dozalash

- Kattalar va 14 yoshdan: 1 tab kuniga 2–3 marta OVQATDAN KEYIN
- Oraliq kamida 4 soat; maks. 3 tab/sut
- Davomiyligi maks. 5–7 kun; vrachsiz maks. 3 kun
- Paratsetamolli boshqa dorilar bilan birga emas

Mumkin emas

Faol yara/qon ketish; jigar va buyrak yetishmovchiligi; yurak yetishmovchiligi NYHA II–IV, YuIK; aspirin astmasi; Jilber, G6FD tanqisligi; Kron, yarali kolit; alkogolizm; insult/TIA; 14 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, dispepsiya, qorin og'riq, GI qon ketish, jigar fermentlari oshishi, bosh og'riq, toshma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ikki mexanizm: diklofenak (yallig'lanish) + paratsetamol (markaziy og'riqsizlantirish, isitma)
- Ginekologiya (dismenoreya, adneksit) va LOR (otit, tonzillit) da ham ko'rsatma bor
- Qisqa kurs uchun

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«O'tkir og'riqda tez yordam!»

- Ikki mexanizm: markaziy og'riqsizlantirish (paratsetamol) + kuchli yallig'lanishga qarshi (diklofenak)
- Stomatologlar va provizorlar uchun

O'zingizni tekshiring

Fanigan tarkibi?

Paratsetamol 500 mg + diklofenak natriy 50 mg.

Fanigan qaysi yoshdan va maksimal sutkalik dozasi?

14 yoshdan; maks. 3 tabletka/sut.

Nimid



Nimesulid

Tabletka 100 mg; granula 100 mg/sashe (apelsin)

NYaQP, COX-2 ga nisbatan selektiv (M01AX17)

QISQACHA · **100 mg kuniga 2 marta ovqatdan keyin, maks. 15 kun. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- O'tkir og'riq
- Birlamchi dismenoreya
- Faqat ikkinchi qator dori sifatida buyuriladi

Dozalash

- Kattalar va 12 yoshdan: 100 mg kuniga 2 marta OVQATDAN KEYIN
- Granula: 1 sashe suvda eritib, kuniga 2 marta
- Maks. 15 kun; minimal samarali doza, qisqa muddat
- KK<30 va jigar yetishmovchiligida mumkin emas

Mumkin emas

ASK/NYaQP ga allergiya; nimesulidga gepatotoksik reaksiya anamnezi; boshqa gepatotoksik dorilar, alkogolizm; faol yara/qon ketish; og'ir yurak, buyrak, jigar yetishmovchiligi; isitma va gripp simptomlari; 12 yoshgacha; homiladorlik III trimestri, laktatsiya

Nojo'ya ta'sirlar

Diareya, ko'ngil aynishi, qusish, jigar fermentlari oshishi; kam — gipertenziya, toshma; juda kam — gepatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Granula — tez so'riladi, yutish qiyin bo'lganlarga qulay
- Gripp/isitma simptomlarida QMBH — tez-tez beriladigan savol
- Varfarin bilan tavsiya etilmaydi

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Nimid granulalar — in'eksiya kabi maksimal tez natija!»

- COX-2 selektiv; me'da va buyrak prostaglandinlariga deyarli ta'sir qilmaydi (kompaniya materiali)

O'zingizni tekshiring

Nimidning maksimal davolash muddati?

15 kun.

Nimid nega gripp simptomlarida mumkin emas?

Yo'riqnomada isitma va gripp simptomlari qo'llash mumkin bo'lmagan holat sifatida ko'rsatilgan (gepatotoksiklik xavfi bilan bog'liq ehtiyot).

Nimid Forte



Nimesulid 100 mg + Tizanidin 2 mg

Tabletka ("NF")

NYaQP + markaziy miorelaksant (M01A)

QISQACHA · **1 tab kuniga 2 marta, maks. 15 kun. Fluvoksamin va siprofloksatsin bilan birga emas.**

Ko'rsatmalar

- Mushak spazmi bilan kechadigan og'riq: artrit, osteoartroz, travmatik shikastlanishlar
- Jarohat/operatsiyadan keyingi og'riq va shish; umurtqa kasalliklari (bo'yin, bel spondilezi)
- Nevrologik spazm: tarqoq skleroz, serebral falaj; og'riqli ginekologik kasalliklar

Dozalash

- Kattalar: 1 tab kuniga 2 marta (ertalab va kechqurun) ovqatdan keyin
- Maks. 15 kun; og'riq ketgach to'xtatish
- KK<30 — mumkin emas

Mumkin emas

> Nimid QMBH + FLUVOKSAMIN yoki SIPROFLOKSATSIN bilan birga (kuchli CYP1A2 ingibitorlari), og'ir jigar yetishmovchiligi, 12 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Nimesulid NT + uyquchanlik, bosh aylanishi, og'iz qurishi, gipotenziya, bradikardiya, holsizlik

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ikki muammoni bitta tabletkada yopadi: yallig'lanish + mushak spazmi
- Haydovchilarni uyquchanlikdan ogohlantirish
- Antigipertenziv dorilar bilan gipotenziya ehtimoli

O'zingizni tekshiring

Nimid Forte qaysi dorilar bilan mumkin emas?

Fluvoksamin va siprofloksatsin (tizanidin konsentratsiyasini keskin oshiradi).

Nimid Forte dozasi?

1 tabletka kuniga 2 marta ovqatdan keyin, maks. 15 kun.

Nimid gel

Nimesulid 1% (10 mg/g)

Gel 30 g / 100 g

Mahalliy NYaQP (M02AA26)



QISQACHA · **~3 sm gel kuniga 3–4 marta, ishqalamasdan surtiladi. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Tayanch-harakat apparatining yallig'lanish va degenerativ kasalliklari: RA, podagrik, psoriatik artrit, Bexterev, osteoartrit, bursit, tendinit, osteoxondroz, ishias, lyumbago
- Yumshoq to'qima jarohatlari, paylar cho'zilishi; zo'riqishdan keyingi og'riq

Dozalash

- ~3 sm gelni og'riqli joyga yupqa qatlam, ISHQALAMASDAN surtish
- Kuniga 3–4 marta; toza, quruq teriga

Mumkin emas

> Dermatit, epidermis shikastlanishi, teri infeksiyasi; aspirin astmasi; homiladorlik III trimestri; 12 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Surtilgan joyda qichishish, po'st tashlash, toshma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ishqalamasdan surtiladi — tez-tez so'raladigan nuqta
- Okklyuziv bog'lam qo'yilmaydi
- Tabletka bilan birga mahalliy davo sifatida

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Nimid gel — tez og'riqsizlantirish!»

- Tez so'riladi, kiyimda dog' qoldirmaydi, achishtirmaydi, yoqimli hid — uzoq qo'llashga qulay
- Tog'ayga zarar yetkazmaydi; sinovial suyuqlikka kiradi
- Endokrinologlar uchun: autoimmun tireoiditli bemorlarda xavfsiz gel (kompaniya da'vosi)

O'zingizni tekshiring

Nimid gel qanday surtiladi?

3 sm gel yupqa qatlamda, ishqalamasdan, kuniga 3–4 marta.

Nimid gel qaysi yoshdan?

12 yoshdan.

Dikloseyf

Diklofenak natriy

Rektal supp. 50 / 100 mg

NYaQP (M01AB05)



QISQACHA · 75–150 mg/sut; 100 mg sham kuniga 1 marta kechqurun mumkin. Maks. 150 mg/sut. Proktitda mumkin emas.

Ko'rsatmalar

- Artritlar (RA, OA, ankilozlovchi spondilit, o'tkir podagra)
- Periartrit, tendinit, tenosinovit, bursit
- Jarohatlar, bel og'rig'i, ortopedik/stomatologik/kichik jarrohlikdan keyingi og'riq

Dozalash

- Kattalar: 75–150 mg/sut bir necha marta; 100 mg supp kuniga 1 marta kechqurun mumkin
- Maks. 150 mg/sut (tabletka bilan birga hisoblaganda)
- Defekatsiyadan keyin, faqat rektal; bolalarga tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

Sezuvchanlik; faol yara, qon ketish yoki perforatsiya; NYaQP bilan bog'liq GI qon ketish anamnezi; qaytalanuvchi yara (2+ epizod); homiladorlik III trimestri; jigar va buyrak yetishmovchiligi; yurak yetishmovchiligi NYHA II–IV, YuIK, periferik arteriya/serebrovaskulyar kasallik; ASK/NYaQP chaqirgan astma, angioedema, eshakemi, rinit; PROKTIT

Nojo'ya ta'sirlar

Tez-tez: ko'ngil aynishi, qusish, diareya, dispepsiya, qorin og'riq, bosh og'riq, bosh aylanishi, vertigo, transaminazalar oshishi, toshma; kam: mahalliy yallig'lanish, GI qon ketish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Rektal yo'l — tabletka yuta olmaydigan yoki ko'ngil aynishi bo'lgan bemorga
- Keksalarda minimal doza, GI himoya

O'zingizni tekshiring

Dikloseyf shamining maksimal sutkalik dozasi?

150 mg (boshqa diklofenak shakllari bilan birga).

Dikloseyf shami qachon yuboriladi?

Ichak bo'shatilgandan keyin; 100 mg ni kechqurun kuniga 1 marta qo'llash mumkin.

Dikloseyf Maks gel



Diklofenak natriy 5% (50 mg/g)

Gel

Mahalliy NYaQP (M02AA15)

QISQACHA · **0,8–1 g gel kuniga 3 marta, maks. 3 g/sut. Vrachsiz 7 kungacha. 14 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Kichik va o'rta bo'g'im atrofi jarohatlari (cho'zilish, lat yeyish) va mahalliy yallig'lanishda yengil-o'rta og'riq

Dozalash

- 14 yoshdan: 0,8–1,0 g gel kuniga 3 marta; maks. 3 g/sut
- Vrachsiz 7 kundan ko'p emas; 3 kunda yaxshilanmasa — vrachga

Mumkin emas

Diklofenak/NYaQP ga sezuvchanlik; ASK chaqirgan astma/eshakemi/rinit; homiladorlik III trimestri; emizikli ayolda ko'krakka; 14 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Toshma, ekzema, eritema, qichishish; juda kam — fotosensibilizatsiya, astma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- 5% — yuqori konsentratsiya, kam miqdor yetarli
- Quyoshdan saqlash; shikastlangan teriga emas

O'zingizni tekshiring

Dikloseyf Maks gelning maksimal sutkalik miqdori?

3 g gel (150 mg diklofenak).

Vrachsiz qancha ishlatish mumkin?

7 kundan ko'p emas; 3 kunda yaxshilanmasa vrachga.

Fanigan Fast gel



Diklofenak dietilamin 1% + Metilsalitsilat 10% + Mentol 5% + Zig'ir moyi 3%

Gel

Mahalliy NYaQP kombinatsiyasi (M02AA15)

QISQACHA · **2–4 g gel (4–8 sm) kuniga 2–3 marta, maks. 10 g/sut. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- RA, Bexterev, podagrik, psoriatik, posttravmatik artrit; tendovaginit, bursit, miozit
- Osteoartroz, osteoxondroz, mialgiya, nevralgiya, radikulit
- Jarohat, lat yeyish, cho'zilish, og'ir yuklamadan keyingi mushak og'rig'i

Dozalash

- 2–4 g gel (4–8 sm) kuniga 2–3 marta, yengil ishqalab
- Maks. 10 g/sut; vrachsiz 10 kundan ko'p emas

Mumkin emas

> Sezuvchanlik; ochiq jarohat; ASK astma xuruji anamnezi; gastrit/yara xuruji; homiladorlik va laktatsiya; 12 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Kam: toshma, quruqlik, achishish, qichishish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- "Fast": ta'siri bir necha daqiqada boshlanadi, 20–30 daqiqada maksimum
- Mentol — sovutuvchi, metilsalitsilat — chalg'ituvchi og'riqsizlantiruvchi
- Tabletka Fanigan bilan mahalliy qo'shimcha

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Mushaklar va bo'g'imlar og'rig'ida!»

O'zingizni tekshiring

Fanigan Fast tarkibidagi mentolning roli?

Sovutuvchi, chalg'ituvchi ta'sir — og'riqni tez yengillatadi.

Fanigan Fast maksimal sutkalik miqdori?

10 g gel.

Panash krem



Tiokolxikozid 0,25% (2,5 mg/g)

Krem 30 g

Markaziy ta'sirli miorelaksant (M03BX05)

QISQACHA · **Kuniga 2–3 marta, kurs 7–10 kun. Homiladorlik va emizishda mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Bel-dumg'aza radikuliti, servikobraxialgiya (bo'yin, yelka mushak og'rig'i, kontraktura)
- Mushak rigidligi, operatsiyadan keyingi og'riq
- O'tkir umurtqa patologiyasida og'riqli mushak kontrakturasi — yordamchi

Dozalash

- Shikastlangan joyga kuniga 2–3 marta ozgina ishqalab
- Kurs 7–10 kun
- 17 yoshgacha qo'llanmaydi

Mumkin emas

> Sezuvchanlik; periferik falaj; mushak gipotoniyasi; homiladorlik; laktatsiya; kontratsepsiya qilmayotgan tug'ish yoshidagi ayollar

Nojo'ya ta'sirlar

Toshma; kam — uyquchanlik

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Mahalliy miorelaksant — tizimli so'rilish minimal
- NYaQP (gel/tabletka) bilan kombinatsiya — og'riq + spazm
- Tutqanoq anamnezida ehtiyot

O'zingizni tekshiring

Panash kremining ta'sir etuvchi moddasi va guruhi?

Tiokolxikozid — markaziy ta'sirli miorelaksant.

Panash kimga mumkin emas?

Homilador, emizikli, kontratsepsiya qilmayotgan ayollar, periferik falaj, mushak gipotoniyasi.

Serrata



Serratiopeptidaza

Ichakda eruvchan tabletka 10 mg; strip 30 tab (qutida 1, 5 yoki 10 strip)

Proteolitik ferment, yallig'lanishga va shishga qarshi (M09AB)

QISQACHA · **10 mg kuniga 2–3 marta ovqatdan keyin, maks. 30 mg/sut. Qon ivishi buzilishida mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Jarrohlikdan keyingi shish (tish olish, suyak sinishi, plastik jarrohlik)
- Nafas yo'llari: balg'amni suyultiradi; LOR: burun bo'shlig'i sekreti
- Teri: o'tkir yallig'lanish dermatozlari; gematomalar, sut bezlari kattalashuvi

Dozalash

- Kattalar: 1 tab kuniga 2–3 marta ovqatdan keyin
- Chaynamay, bir stakan suv bilan
- Maks. 30 mg/sut

Mumkin emas

> O'ta sezuvchanlik; qon ivishi buzilishi

Nojo'ya ta'sirlar

Diareya, ko'ngil aynishi, qusish, anoreksiya, epigastral noqulaylik; kam — toshma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Antibiotiklarning yallig'langan to'qimaga kirishini kuchaytiradi
- Antikoagulyantlar ta'sirini kuchaytiradi — ehtiyot
- Bolalar va homiladorlarga tavsiya etilmaydi

O'zingizni tekshiring

Serrata antibiotiklar bilan qanday ishlaydi?

Antibiotiklarning yallig'lanish o'chog'iga kirishini tezlashtiradi.

Serratada asosiy QMBH?

Qon ivishining buzilishi va o'ta sezuvchanlik.

Lefno



Leflunomid

Tabletka 20 mg

Selektiv immunodepressant, bazis antirevmatik (L04AA13)

QISQACHA · 3 kun 100 mg/sut, keyin 10–20 mg/sut. ALT va qon tahlili dastlabki 6 oy har 2 haftada.

Ko'rsatmalar

- Kattalarda faol revmatoid artrit
- Faol psoriatik artrit

Dozalash

- Yuklama: 100 mg kuniga 1 marta 3 kun
- RA: keyin 10–20 mg/sut; PsA: 20 mg/sut
- Samara 4–6 haftada, 4–6 oygacha yaxshilanadi
- Nazorat: ALT va qon tahlili — dastlabki 6 oy har 2 haftada, keyin har 8 haftada

Mumkin emas

> Jigar buzilishi; og'ir immunodefitsit; suyak iligi buzilishi; og'ir infeksiya; o'rta-og'ir buyrak yetishmovchiligi; homiladorlik va kontratsepsiyasiz tug'ish yoshi; emizish

Nojo'ya ta'sirlar

AQB oshishi, leykopeniya, diareya, ko'ngil aynishi, og'iz yarachalari, soch to'kilishi, toshma, jigar fermentlari oshishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Davolashni revmatolog boshlaydi; metotreksat bilan birga — gepatotoksiklik xavfi
- Faol metabolit T½ ≈ 2 hafta — kerak bo'lsa xolestiramin bilan "yuvish"
- 18 yoshgacha tavsiya etilmaydi

O'zingizni tekshiring

Lefno qanday boshlanadi?

3 kun davomida 100 mg/sut yuklama dozasi, keyin 10–20 mg/sut.

Lefno bilan qanday tahlillar nazorat qilinadi?

ALT va qonning umumiy tahlili: dastlabki 6 oy har 2 haftada, keyin har 8 haftada.

Alendra



Natriy alendronat 70 mg

Tabletka

Bisfosfonat, suyak rezorbsiyasi ingibitori (M05BA04)

QISQACHA · 70 mg haftasiga 1 marta, ertalab och qoringa, oddiy suv bilan; keyin 30 daqiqa yotmaslik.

Ko'rsatmalar

- Postmenopauzal osteoporoz (umurtqa va son suyagi sinishi xavfini kamaytiradi)

Dozalash

- HAFTASIGA 1 MARTA 70 mg
- Ertalab, ovqat/ichimlik/doridan kamida 30 daqiqa oldin, faqat ODDIY SUV (≥200 ml) bilan
- Tik turib yoki o'tirib; keyin 30 daqiqa yotmaslik; chaynamaslik, so'rmaslik
- Ovqatda yetarli bo'lmasa kalsiy va vitamin D qo'shish
- O'tkazib yuborilsa — eslagan kunining ertasi ertalab; KK <35 tavsiya etilmaydi; 18 yoshgacha qo'llanmaydi

Mumkin emas

Qizilo'ngach anomaliyalari (striktura, axalaziya); 30 daqiqa tik tura olmaslik; gipokalsiemiya; o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Qorin og'riq, dispepsiya, zarda, qizilo'ngach yarasi, suyak-mushak og'rig'i, bosh og'riq; kam — jag' osteonekrozi, son suyagining atipik sinishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Qabul qoidasiga rioya — samaradorlik va xavfsizlikning asosiy sharti
- Mineral suv, kofe, sharbat so'rilishni kamaytiradi
- Forkal Plyus bilan kalsiy/D ta'minoti (boshqa vaqtda)

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Alendra — osteoporozning oldini olish va davolashda "oltin standart"»

- Yevropa va AQSh ishlab chiqarish standartlari
- Narxi qulay

O'zingizni tekshiring

Alendra qanday ichiladi?

Haftasiga 1 marta, ertalab och qoringa, faqat oddiy suv bilan, tik holatda; 30 daqiqa yotmaslik va ovqat yemaslik.

Alendra uchun QMBH?

Qizilo'ngach anomaliyalari, 30 daqiqa tik tura olmaslik, gipokalsiemiya, o'ta sezuvchanlik.

Forkal Plyus



Kalsiy sitrat (Ca 252 mg) + Kalsitriol 0,25 mkg

Tabletka

Mineral qo'shimcha, vitamin D ning faol shakli bilan (A12AX)

QISQACHA · **Kalsiy sitrat + kalsitriol (faol D vitamini). Kattalar 1–2 tab/sut.**

Ko'rsatmalar

- Kalsiy tanqisligi (osteomalyatsiya, raxit, malabsorbsiya)
- Osteoporoz: suyak mineral yo'qotilishini sekinlatish (standart terapiyaga qo'shimcha)
- Ehtiyoj ortgan davr: bolalik, qarilik, homiladorlik, emizish

Dozalash

- Kattalar: 1–2 tab/sut (250–500 mg kalsiy)
- Osteoporoz: 1 tab/sut
- Bolalar: 6–10 yosh 1 tab/sut; 10 yoshdan 2 tab/sut
- Ovqatdan qat'i nazar

Mumkin emas

Giperkalsiemiya (giperparatireoz, D gipervitaminozi, o'smalar, og'ir buyrak yetishmovchiligi, suyak metastazlari); og'ir giperkalsiuriya, kalsiyli buyrak toshlari; uzoq immobilizatsiya

Nojo'ya ta'sirlar

Kam: giperkalsiemiya, giperkalsiuriya, ko'ngil aynishi, qorin og'riq, qabziyat, qichishish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Kalsiy SITRAT — me'da kislotaligidan qat'i nazar so'riladi (keksalar, IPP qabul qiluvchilar)
- KALSITRIOL — jigar va buyrakda faollashuv talab qilmaydi
- Uzoq qabulda kalsiy darajasini nazorat

O'zingizni tekshiring

Forkal Plyusdagi kalsitriolning afzalligi?

Vitamin D ning faol shakli — jigar va buyrakda faollashuvni talab qilmaydi.

Osteoporozda Forkal Plyus dozasi?

1 tabletka kuniga.

Ginekologiya

7 ta preparat

Banbakt
Gayneks / Gayneks Forte
Mistol
Kandigo
Dermazol shamlari
Vidanol
Suprileks

Banbakt



Klindamitsin 100 mg (fosfat)

Vaginal suppozitoriy

Ginekologik antibakterial (G01AA10)

QISQACHA · **Bakterial vaginoz: 1 sham kuniga 1 marta, 3 kun.**

Ko'rsatmalar

- Homilador bo'lmagan ayollarda bakterial vaginoz — 3 kunlik kurs

Dozalash

- 1 supp kuniga 1 marta, yaxshisi uxlashdan oldin, ketma-ket 3 kun

Mumkin emas

> Klindamitsin/linkomitsinga sezuvchanlik; regional enterit, yarali kolit yoki antibiotik bilan bog'liq kolit anamnezi

Nojo'ya ta'sirlar

Vulvovaginal bezovtalik, vaginal og'riq, vaginal kandidoz; kam — psevdomembranoz kolit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Qisqa kurs — 3 kun
- Lateks prezervativ/diafragma — davolashdan keyin 72 soat ishlatmaslik
- Neyro-mushak blokatorlari ta'sirini kuchaytiradi

O'zingizni tekshiring

Banbakt kursi?

1 suppozitoriy kuniga 1 marta, ketma-ket 3 kun.

Banbaktdan keyin lateks kontratseptivlar haqida nima deyish kerak?

72 soat davomida ishlatmaslik — mustahkamligi pasayadi.

Gayneks / Gayneks Forte



Metronidazol + Mikonazol nitrat

Vaginal supp.: Gayneks 500/100 mg; Forte 750/200 mg

Antibakterial, protozoyga va zamburug'ga qarshi (G01AF20)

QISQACHA · **1 sham kechqurun, 7 kun (qaytalanishda 14 kun). Davolash davomida va 3 kun keyin spirt mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Candida albicans vulvovaginiti
- Bakterial vaginoz
- Trichomonas vaginiti
- Aralash vaginal infeksiyalar

Dozalash

- 1 supp kechqurun qinga chuqur, 7 kun
- Qaytalanuvchi yoki chidamli holatda 14 kun
- Hayz paytida ishlatilmaydi; 18 yoshgacha qo'llanmaydi

Mumkin emas

> Sezuvchanlik; davolash davomida va 3 kun keyin alkogol; 2 hafta ichida disulfiram; homiladorlik I trimestri; porfiriya, epilepsiya, og'ir jigar yetishmovchiligi

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, bosh aylanishi, vulvovaginal achishish, qichishish, metall ta'mi, qorin og'riq

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Bitta shamcha — 3 xil qo'zg'atuvchiga: bakteriya, trixomonada, zamburug'
- Forte — yuqori doza, og'irroq holatlarga
- Alkogol bilan disulfiramsimon reaksiya

O'zingizni tekshiring

Gayneks bilan Gayneks Forte farqi?

Dozasi: Gayneks 500/100 mg, Forte 750/200 mg (metronidazol/mikonazol).

Gayneks bilan davolanganda spirt haqida qoida?

Davolash davomida va tugagandan keyin 3 kun spirt mumkin emas.

Mistol



Metronidazol 500 mg

Vaginal suppozitoriy

Antiprotozoy, antibakterial (J01XD01)

QISQACHA · **Trixomonoz — 10 kun, nospetsifik vaginit — 7 kun (kuniga 1 sham). Jinsiy sherik ham davolanadi.**

Ko'rsatmalar

- Trixomonadali vaginit
- Nospetsifik (bakterial) vaginit
- Anaerob infeksiyalar

Dozalash

- Trixomonoz: 1 supp kuniga 1 marta 10 kun
- Nospetsifik vaginit: 1 supp kuniga 1 marta 7 kun
- Faqat kattalar; jinsiy sherikni ham davolash; maks. 10 kun, yiliga 2–3 kurs

Mumkin emas

> Nitroimidazollarga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Kam: toshma, qichishish, ko'ngil aynishi, metall ta'mi, bosh og'riq, siydik qorayishi; juda kam — neyropatiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Davolash davomida va 48 soat keyin spirt mumkin emas
- Varfarin, litiy, disulfiram, siklosporin, 5-FU bilan o'zaro ta'sir

O'zingizni tekshiring

Trixomonadali vaginitda Mistol kursi?

1 suppozitoriy kuniga 1 marta, 10 kun.

Mistoldan keyin spirt qachondan mumkin?

Davolash tugaganidan kamida 48 soat o'tgach.

Kandigo



Klotrimazol

Vaginal supp. 100 mg / 500 mg; 10% vaginal krem (applikator bilan)

Zamburug'ga qarshi, imidazol (G01AF02)

QISQACHA · **500 mg sham yoki 10% krem — bir marta; 100 mg sham — 3 kun.**

Ko'rsatmalar

- Kandidozli vaginit

Dozalash

- Supp 100 mg: kuniga 1 marta (kechqurun) 3 kun yoki 6 kun
- Supp 500 mg: BIR MARTA kechqurun
- Krem 10%: to'ldirilgan applikator BIR MARTA kechqurun; kerak bo'lsa takrorlash
- Hayz paytida emas; krem 16 yoshgacha qo'llanmaydi

Mumkin emas

> Klotrimazol yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Allergik reaksiya, qichishish, toshma, shish, achishish, qorin og'riq

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- 500 mg va krem — bir martalik davo, qulay
- Lateks kontratseptivlar — 5 kun ehtiyot; takrolimus/sirolimus darajasini oshirishi mumkin
- 7 kunda yaxshilanmasa yoki 6 oyda 2 dan ko'p qaytalansa — vrachga

O'zingizni tekshiring

Kandigo 500 mg qanday qo'llanadi?

Bitta suppozitoriy bir marta kechqurun qinga chuqur.

Kandigodan keyin lateks prezervativ haqida?

Kamida 5 kun ehtiyot choralarini ko'rish — lateks shikastlanishi mumkin.

Dermazol shamlari



Ketokonazol 400 mg

Vaginal suppozitoriy, №10

Zamburug'ga qarshi, imidazol (G01AF11)

QISQACHA · **400 mg kuniga 1 marta, 3–5 kun; surunkali kandidozda 10 kun. Homiladorlikda mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- O'tkir va surunkali qaytalanuvchi vaginal kandidoz
- Antibiotik/mikroflorani buzuvchi dorilar fonida vaginal mikoz profilaktikasi

Dozalash

- 1 supp kechqurun qinga chuqur, 3–5 kun
- Surunkali kandidozda 10 kun

Mumkin emas

Ketokonazolga sezuvchanlik; homiladorlik; emizish; 18 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Qinda giperemiya va qichishish; allergik toshma, eshakemi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Tizimli so'rilish kam — o'zaro ta'sir ehtimoli past
- Jinsiy sherikni ham davolash; lateks kontratseptivlar ishonchliligi kamayadi
- Paxta ichki kiyim, gigiyena maslahatlari

O'zingizni tekshiring

Surunkali vaginal kandidozda Dermazol shamlari kursi?

1 suppozitoriy kuniga 1 marta, 10 kun.

Dermazol shamlari kimga mumkin emas?

Homilador, emizikli ayollar, 18 yoshgacha va ketokonazolga sezuvchanlikda.

Vidanol



Traneksam kislota 500 mg

Tabletka

Antifibrinolitik, gemostatik (B02AA02)

QISQACHA · **Menorragiya: 1 g kuniga 3 marta, 4 kungacha. Tromboz va tromboemboliyada mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Menorragiya (ko'p hayz qon ketishi)
- Giperfibrinoliz bilan qon ketishlar: prostata operatsiyasi, gematuriya, burun qonashi, gifema, bachadon bo'yni konizatsiyasi, tonzillektomiya
- Gemofiliyada tish olish; irsiy angionevrotik shish

Dozalash

- Menorragiya: 1 g kuniga 3 marta, 4 kungacha (maks. 4 g/sut), hayz boshlanganda
- Mahalliy fibrinoliz: 1–1,5 g 2–3 marta, 3–15 kun
- Burun qonashi: 1 g ×3, 7 kun; konizatsiya: 1,5 g ×3, 12 kungacha
- Gemofiliyada tish olish: 25 mg/kg har 8 soatda (1 kun oldin boshlab)
- Buyrak buzilishida dozani kamaytirish

Mumkin emas

> Og'ir buyrak yetishmovchiligi; yuqori siydik yo'llaridan makroskopik gematuriya; tromboemboliya; o'tkir vena/arterial tromboz

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, qusish, diareya, toshma, bosh aylanishi; kam — tromboemboliya, rang ko'rish buzilishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ginekolog, LOR, urolog, stomatolog uchun
- Ko'rish buzilsa — oftalmologik tekshiruv
- 12 yoshdan bolalarda 20–25 mg/kg

O'zingizni tekshiring

Menorragiyada Vidanol dozasi?

1 g kuniga 3 marta, 4 kungacha; maks. 4 g/sut.

Vidanol qaysi gematuriyada mumkin emas?

Yuqori siydik yo'llaridan makroskopik gematuriyada (laxta bilan obstruksiya xavfi).

Suprileks



Izoksuprin 10 mg

Tabletka

Periferik vazodilatator, beta-adrenomimetik, tokolitik (C04AA01)

QISQACHA · **Muddatidan oldin tug'ish xavfi: 20 mg kuniga 4 marta, 2 kun. Qon aylanishi buzilishi: 10–20 mg 3–4 marta.**

Ko'rsatmalar

- Muddatidan oldin tug'ish xavfi (in'eksion davodan keyin)
- Periferik qon aylanishi buzilishi: arteriospazm, oblitlovchi endarteriit, diabetik angiopatiya, Reyno
- Surunkali serebrovaskulyar yetishmovchilik (aterosklerotik)

Dozalash

- Tug'ish xavfi: v/i davodan keyin 20 mg kuniga 4 marta, 2 sutka
- Qon aylanishi: 10–20 mg kuniga 3–4 marta ovqatdan keyin, 2–3 oy

Mumkin emas

> Sezuvchanlik; yaqinda serebral qon ketish, metrorragiya, arterial qon ketish; stenokardiya; gipotenziya; laktatsiya

Nojo'ya ta'sirlar

Taxikardiya, yurak urishi, gipotenziya, ko'krak og'rig'i, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi; homilada taxikardiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ortostatik gipotenziya — asta turish
- Chekish samarani kamaytiradi; alkogol mumkin emas
- Homiladorlikda faqat muddatidan oldin tug'ish xavfida

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Suprileks — qon aylanishini yaxshilash uchun O'zbekistonda yagona periferik vazodilatator»

- Shifokorlar: xirurg, revmatolog, endokrinolog

O'zingizni tekshiring

Muddatidan oldin tug'ish xavfida Suprileks sxemasi?

In'eksion davodan keyin 20 mg kuniga 4 marta, 2 sutka.

Suprileksning asosiy nojo'ya ta'siri?

Taxikardiya va gipotenziya (ona va homilada).

Urologiya va andrologiya

3 ta preparat

Arstifen

Katariya

Moginin

Arstifen



Limon kislota + Natriy sitrat + Kaliy bikarbonat

Shipuchi tabletka

Siydik toshlarini erituvchi (G04BC)

QISQACHA · **Doza siydik pH bo'yicha tanlanadi; urat toshlarida pH 7,0–7,2.**

Ko'rsatmalar

- Urat toshlari litolizi va profilaktikasi; aralash urat-oksalat toshlar
- Kalsiy-oksalat toshlar qaytalanishi profilaktikasi
- Sitostatik/urikozurik davoda siydikni ishqorlash; sistin toshlari; gipersuriksemiya

Dozalash

- Kuniga 2–5 tab suvda yoki sharbatda eritib, 3 ga bo'lib (8:00, 14:00, 21:00)
- Siydik pH ni indikator qog'oz bilan nazorat: uratlar 7,0–7,2; aralash 6,8–7,4; sistin 7,5–8,5
- Kurs 4 hafta – 6 oy

Mumkin emas

> Buyrak yetishmovchiligi; ureaza hosil qiluvchi bakteriyalar bilan siydik infeksiyasi; metabolik alkaloz; o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, qorin og'riq, meteorizm, diareya; allergiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Doza siydik pH bo'yicha individual tanlanadi — indikator qog'oz
- Allopurinol samarasini kuchaytiradi
- Kaliy tejovchi diuretik, APF, sartan bilan giperkaliemiya xavfi

O'zingizni tekshiring

Urat toshlarida qanday siydik pH saqlanadi?

7,0–7,2.

Arstifen dozasi qanday tanlanadi?

Siydik pH ni indikator qog'oz bilan o'lchab, kuniga 2–5 tabletka, 3 ga bo'lib.

Katariya



Natriy sitrat 4 g

Granula, sashe (klyukva ta'mi), №6

Siydikni ishqorlovchi (G04BX)

QISQACHA · **Faqat ayollar: 1 sashe kuniga 3 marta, 2 kun. Diabet va gipertenziyada mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Ayollarda sistit simptomlarini (dizuriya) yengillatish

Dozalash

- 1 sashe 1 stakan suvda, kuniga 3 marta, 48 soat (2 kun)
- Erkaklar va bolalarga tavsiya etilmaydi; 2 kunda o'tmasa — vrachga

Mumkin emas

Qandli diabet; yurak-qon tomir kasalliklari; arterial gipertenziya; past tuzli parhezdagi buyrak kasalligi; homiladorlik va emizish

Nojo'ya ta'sirlar

Juda kam: toshma, qorin og'riq

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Har dozada 939 mg natriy — gipertenziyada mumkin emas
- Saxaroza bor — diabetda mumkin emas
- Antibiotik o'rnini bosmaydi — simptomatik

O'zingizni tekshiring

Katariya kursi?

1 sashe kuniga 3 marta, 2 kun (48 soat).

Katariya kimga mumkin emas?

Qandli diabet, gipertenziya, yurak-qon tomir kasalligi, homiladorlik, emizish.

Moginin

Sildenafil

Tabletka 50 mg / 100 mg

FDE-5 ingibitori (G04BE03)



QISQACHA · 50 mg jinsiy faollikdan ~1 soat oldin. Nitratlar bilan mumkin emas.

Ko'rsatmalar

- Erkaklarda erektil disfunksiya

Dozalash

- 18–65 yosh: 50 mg jinsiy faollikdan ~1 soat oldin
- Samaraga qarab 100 mg gacha yoki 25 mg gacha; kuniga 1 martadan ko'p emas
- Boshlang'ich 25 mg: KK<30, sirroz, CYP3A4 ingibitorlari, alfa-blokatorlar

Mumkin emas

NITRATLAR va azot oksidi donatorlari bilan; nostabil stenokardiya, og'ir yurak yetishmovchiligi; NAION; og'ir jigar yetishmovchiligi; AQB <90/50; yaqinda insult yoki infarkt; pigmentli retinit

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, bosh aylanishi, yuz qizarishi, burun bitishi, dispepsiya, ko'rish/rang buzilishi; priapizm

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Faqat jinsiy qo'zg'alish bo'lganda ta'sir qiladi
- Yog'li ovqat ta'sir boshlanishini kechiktiradi
- 4 soatdan uzoq erektsiya — shoshilinch yordam

O'zingizni tekshiring

Moginin bilan qat'iyan mumkin bo'lmagan dorilar?

Nitratlar va azot oksidi donatorlari (amilnitrit).

Moginin boshlang'ich dozasi qachon 25 mg?

Og'ir buyrak buzilishi, sirroz, CYP3A4 ingibitorlari yoki alfa-blokatorlar qabul qilinganda.

Dermatologiya

9 ta preparat

Blemish gel
Baktopik surtma
Baktopik nazal surtma
Dermazol krem 2%
Dermazol shampun 2%
Dermazol Plyus shampun
Fusis gel 0,5%
Remov loson 4%
Volvit

Blemish gel



Adapalen 0,1% + Klindamitsin 1%

Gel 15 g

Akne uchun mahalliy kombinatsiya (D10AD53)

QISQACHA · **Kuniga 1 marta kechqurun; samara 8–12 haftada. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Oddiy husnbuzar (akne vulgaris) — mahalliy davo

Dozalash

- Kuniga 1 marta KECHQURUN, toza quruq teriga yupqa qatlam
- Dastlabki haftalarda akne vaqtincha kuchayishi mumkin
- Samara 8–12 haftada; 12 yoshdan

Mumkin emas

> Adapalen, klindamitsin yoki linkomitsinga sezuvchanlik; enterit, yarali kolit, antibiotik bilan bog'liq kolit anamnezi; Kron

Nojo'ya ta'sirlar

Quruqlik, qizarish, achishish, qichishish, po'st tashlash; kam — diareya, kolit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Retinoid (komedonlarga) + antibiotik (yallig'lanishga) — ikki mexanizm
- Eritromitsin bilan birga emas; boshqa qitiqlovchi vositalar ehtiyot
- Quyosh/UV dan saqlanish; homiladorlikda tavsiya etilmaydi

O'zingizni tekshiring

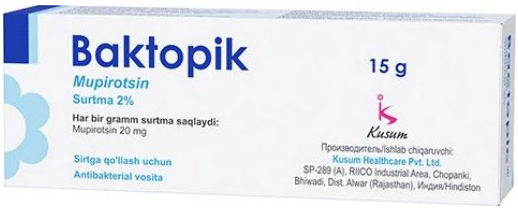
Blemish qachon va necha marta surtiladi?

Kuniga 1 marta kechqurun, toza quruq teriga.

Blemish bilan birinchi haftalarda nima bo'lishi mumkin?

Akne vaqtincha kuchayishi — bu davolashni to'xtatish sababi emas.

Baktopik surtma



Mupirotsin 2%

Surtma

Mahalliy antibiotik (D06AX09)

QISQACHA · **Kuniga 2–3 marta, 10 kungacha. 2 oylikdan.**

Ko'rsatmalar

- S. aureus (MRSA ham) va streptokokklar keltirgan teri infeksiyalari: impetigo, follikulit, furunkulyoz

Dozalash

- Kattalar va 2 oylikdan bolalar: kuniga 2–3 marta, 10 kungacha
- Bog'lam ostida ham mumkin; 10 kunda samara bo'lmasa qayta baholash

Mumkin emas

> Mupirotsinga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Surtilgan joyda achishish; kam — qichishish, qizarish, quruqlik

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Boshqa antibiotiklar bilan kesishgan rezistentlik yo'q (o'ziga xos mexanizm)
- Ko'z va burun ichiga mos emas (buning uchun nazal shakli bor)
- PEG — o'rta/og'ir buyrak yetishmovchiligida ehtiyot

O'zingizni tekshiring

Baktopik surtma qaysi yoshdan?

2 oylikdan.

Baktopik qaysi infeksiyalarda?

Impetigo, follikulit, furunkulyoz (S. aureus, shu jumladan MRSA, streptokokklar).

Baktopik nazal surtma



Mupirotsin kalsiy (mupirotsin 2%)

Burun uchun surtma

Mahalliy antibiotik (D06AX09)

QISQACHA · **Burun teshiklariga kuniga 2–3 marta; tashuvchanlik odatda 5–7 kunda yo'qoladi.**

Ko'rsatmalar

- Stafilokokklar, shu jumladan MRSA ning burun orqali tashuvchanligini bartaraf etish

Dozalash

- Gugurt cho'pi boshidek miqdor har bir burun teshigi ichiga kuniga 2–3 marta
- Keyin burun qanotlarini siqib tarqatish
- Tashuvchanlik odatda 5–7 kunda yo'qoladi

Mumkin emas

> Mupirotsinga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Burun shilliq qavati reaksiyalari; juda kam — tizimli allergiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Operatsiyadan oldin va shifoxona ichi infeksiyasi profilaktikasida
- Ko'zga ishlatilmaydi

O'zingizni tekshiring

Baktopik nazal surtmaning ko'rsatmasi?

MRSA va boshqa stafilokokklarning burun orqali tashuvchanligini bartaraf etish.

Necha kunda tashuvchanlik yo'qoladi?

Odatda 5–7 kunda.

Dermazol krem 2%



Ketokonazol 20 mg/g

Krem 15 g / 30 g

Zamburug'ga qarshi (D01AC08)

QISQACHA · **Kuniga 1–2 marta; simptomlar ketgach yana kamida 1 hafta.**

Ko'rsatmalar

- Teri kandidozi
- Dermatomikozlar: qo'l, oyoq, tana, chov epidermofitiyasi
- Kepaklanuvchi (rangli) temiratki
- Seboreyali dermatit

Dozalash

- Kattalar: kuniga 1–2 marta
- Kurs: chov 2–4 hafta; kandidoz va temiratki 2–3 hafta; oyoq 4–6 hafta
- Simptom yo'qolgach yana kamida 1 hafta; 4 haftada yaxshilanmasa — vrachga

Mumkin emas

Ketokonazolga sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Achishish, qizarish, qichishish; kam — kontakt dermatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Steroid krem ishlatgan bo'lsa: 2–3 hafta ertalab steroid, kechqurun Dermazol, asta o'tish
- Retseptsiz; ko'zga emas

O'zingizni tekshiring

Oyoq epidermofitiyasida Dermazol krem kursi?

4–6 hafta.

Dermazol kremni simptomlar ketgach qancha davom ettirish kerak?

Yana kamida 1 hafta.

Dermazol shampun 2%



Ketokonazol 20 mg/ml

Sashe 8 ml №20; flakon 50/100 ml

Zamburug'ga qarshi (D01AC08)

QISQACHA · **Davolash: haftasiga 2 marta, 2–4 hafta; 3–5 daqiqa qoldirib yuviladi. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Seboreyali dermatit, qazg'oq (perhot), kepaksimon temiratki — davolash va profilaktika

Dozalash

- Surtib 3–5 daqiqa qoldirib yuviladi; 12 yoshdan
- Davolash: qazg'oq/seboreya — haftasiga 2 marta 2–4 hafta; temiratki — kuniga 1 marta 5 kungacha
- Profilaktika: qazg'oq/seboreya — 1–2 haftada 1 marta; temiratki — 3 kungacha (yozdan oldin)

Mumkin emas

Ketokonazolga sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Kam: follikulit, teri quruqligi, soch tuzilishi o'zgarishi, toshma, achishish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Retseptsiz
- Steroid vositadan 2–3 hafta asta o'tish

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Qazg'oq kosmetik emas, tibbiy muammo! Dermazol shampunlari bilan qazg'oqdan butunlay xalos bo'lasiz»

O'zingizni tekshiring

Qazg'oqda Dermazol shampun sxemasi?

Haftasiga 2 marta, 2–4 hafta; profilaktikada 1–2 haftada 1 marta.

Shampun boshda necha daqiqa qoldiriladi?

3–5 daqiqa.

Dermazol Plyus shampun



Ketokonazol 2% + Rux piritioni 1%

Flakon 60 / 120 ml

Zamburug'ga qarshi (D01AC)

QISQACHA · **Ketokonazol + rux piritioni. Haftasiga 2 marta, 2–4 hafta.**

Ko'rsatmalar

- Qazg'oq, seboreyali dermatit, bosh terisining rangbarang temiratkisi

Dozalash

- Chayqatib, ho'l sochga 3–5 daqiqa
- Qazg'oq/seboreya: haftasiga 2 marta 2–4 hafta; temiratki: 5 kun har kuni
- Profilaktika: 1–2 haftada 1 marta; temiratki — 3 kun

Mumkin emas

Ketokonazol, rux piritioni yoki komponentga sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Teri qizarishi, achishish, qichishish, soch tuzilishi/rangi o'zgarishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Rux piritioni — qo'shimcha antibakterial va zamburug'ga qarshi; aloe — namlaydi
- Bolalarda tajriba yo'q

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Qazg'oqqa qarshi uch tomonlama ta'sir! Boshqa shampunlar ojiz bo'lganda Dermazol Plyus ishlaydi»

- Ketokonazol + rux piritioni + aloe vera: zamburug', sebum va qichishishga ta'sir

O'zingizni tekshiring

Dermazol Plyusni oddiy Dermazol shampundan farqi?

Qo'shimcha rux piritioni (antibakterial va zamburug'ga qarshi) va aloe bor.

Rangbarang temiratkida Dermazol Plyus sxemasi?

5 kun har kuni.

Fusis gel 0,5%



Flukonazol 5 mg/g

Gel 30 g

Zamburug'ga qarshi (D01AC15)

QISQACHA · **Kuniga 1 marta, odatda 1–3 hafta.**

Ko'rsatmalar

- Dermatofit va achitqi zamburug'lari keltirgan dermatomikozlar: Tinea pedis, corporis, cruris, versicolor, Candida

Dozalash

- Kuniga 1 marta zararlangan joy va atrofiga yengil massaj bilan
- Ko'pincha 1–3 haftada; chidamli holatda 6 haftagacha

Mumkin emas

> Flukonazol yoki azollarga sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Kam: yengil qitiqlanish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Kuniga faqat 1 marta — qulay
- Ko'zga emas

O'zingizni tekshiring

Fusis gel necha marta surtiladi?

Kuniga 1 marta.

Fusis gel davolash muddati?

Odatda 1–3 hafta, chidamli holatda 6 haftagacha.

Remov loson 4%



Dimetikon 40 mg/ml

Loson 50 ml (purkagich)

Ektoparazitsid — bitga qarshi (P03AX05)

QISQACHA · **Kamida 8 soat qoldiriladi, 7 kundan keyin takrorlanadi. Yonuvchan.**

Ko'rsatmalar

- Bitlar (pedikulyoz)

Dozalash

- Kattalar va 6 oylikdan: quruq sochga ildizidan uchigacha to'liq ho'llab surtish
- Tabiiy quritib, kamida 8 soat (yoki tun bo'yi) qoldirish, keyin shampun bilan yuvish va taroqlash
- 7 kundan keyin takrorlash

Mumkin emas

Komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Kam: teri qizarishi, qichishish, po'st tashlash, ko'z atrofida yallig'lanish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- FIZIK ta'sir: bitni o'raydi — neyrotoksik insektitsid yo'q, rezistentlik rivojlanmaydi
- YONUVCHAN: surtilgan soch olov va sigaretadan uzoq bo'lsin
- Retseptsiz

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Bitlar ustidan ishonchli g'alaba!»

O'zingizni tekshiring

Remov qanday ta'sir qiladi?

Fizik: bitni o'rab, suv chiqarish tizimini bloklaydi — rezistentlik rivojlanmaydi.

Remov qancha vaqt qoldiriladi?

Kamida 8 soat (yoki tun bo'yi), 7 kundan keyin takrorlanadi.

Volvit



Biotin 5 mg

Tabletka, №30

Vitamin B7 (A11HA05)

QISQACHA · **5 mg kuniga 1 marta, 12 yoshdan. Laboratoriya tahlillariga ta'sir qilishi mumkin.**

Ko'rsatmalar

- Biotin tanqisligi: soch (to'kilish, mo'rtlik), teri (dermatit, seboreya), tirnoq (mo'rtlik, qatlamlanish)
- Malabsorbsiya, biotinidaza yetishmovchiligi
- Psixoemotsional buzilishlar (holsizlik, asabiylik) — tanqislik fonida

Dozalash

- 12 yoshdan: 5 mg kuniga 1 marta ovqatdan oldin
- Malabsorbsiya — 10 mg/sut gacha; tanqislik — 5–20 mg/sut
- Kurs o'rtacha 1 oy

Mumkin emas

Sezuvchanlik; 12 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Juda kam: allergik reaksiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- LABORATORIYA TESTLARINI BUZADI (troponin, gormonlar) — tahlildan oldin vrachga aytish
- Valproat biotin darajasini pasaytiradi; xom tuxum oqi so'rilishni kamaytiradi
- Retseptsiz

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Volvit — soch, tirnoq va teri muammolarini hal qiladi!»

- Biotinning davolovchi dozasi — fermentlarning faol shakllarini hosil qiladi

O'zingizni tekshiring

Volvit qabul qilayotgan bemorga tahlil bo'yicha nima aytish kerak?

Biotin troponin va gormon tahlillarini buzishi mumkin — laboratoriya/vrachni ogohlantirish.

Volvit dozasi?

5 mg kuniga 1 marta, 12 yoshdan.

Infeksiyalar va parazitlar

10 ta preparat

Ziomitsin
Taygeron
Laen
Polimik
Orgil
Fizzi
Fusis
Eszol
Albela
Pirantel

Ziomitsin

Azitromitsin

Tabletka 250 mg / 500 mg

Makrolid (azalid) antibiotik (J01FA10)



QISQACHA · **Odatda 500 mg kuniga 1 marta, 3 kun. Xlamidiyada 1 g bir marta.**

Ko'rsatmalar

- LOR: sinusit, faringit, tonzillit, otit
- Nafas yo'llari: o'tkir bronxit, pnevmoniya
- Teri va yumshoq to'qima: Laym (ko'chib yuruvchi eritema), saramas, impetigo, akne
- Xlamidiya uretriti/servitsiti; H. pylori bilan bog'liq yara

Dozalash

- Ovqatdan 1 soat oldin yoki 2 soat keyin, kuniga 1 marta
- LOR/nafas/teri: 500 mg ×1, 3 kun
- Xlamidiya: 1 g BIR MARTA
- Laym: 1-kun 1 g, 2–5 kun 500 mg; H. pylori: 1 g 3 kun
- Bolalar 25–50 kg: 10 mg/kg, 3 kun

Mumkin emas

Azitromitsin, makrolidlar yoki komponentga o'ta sezuvchanlik; og'ir jigar va buyrak yetishmovchiligi

Nojo'ya ta'sirlar

Diareya (juda tez-tez), qusish, qorin og'riq, ko'ngil aynishi, bosh og'riq; kam — QT uzayishi, gepatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- To'qimada plazmadan ~50 marta yuqori, T½ 2–4 kun — qisqa kurs
- Akne: 6 g kurs (3 kun 500 mg, keyin haftasiga 500 mg 9 hafta)
- Antatsidlar bilan bir vaqtda emas; ergot alkaloidlari bilan tavsiya etilmaydi; digoksin va kolxitsin darajasi oshishi mumkin

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Ziomitsin — barcha kuch uchta tabletkada!»

O'zingizni tekshiring

Ziomitsin qachon ichiladi?

Ovqatdan 1 soat oldin yoki 2 soat keyin, kuniga 1 marta.

Xlamidiyada Ziomitsin dozasi?

1 g bir marta.

Taygeron

Levofloksatsin

Tabletka 500 / 750 mg; infuziya 500 mg/100 ml

Ftorxinolon (J01MA12)



QISQACHA · 500 yoki 750 mg kuniga 1 marta. 18 yoshgacha mumkin emas.

Ko'rsatmalar

- O'tkir bakterial sinusit; surunkali bronxit qaytalanishi; shifoxonadan tashqari pnevmoniya
- Siydik yo'llarining asoratli infeksiyalari, pielonefrit; surunkali bakterial prostatit
- Teri va yumshoq to'qima asoratli infeksiyalari; ingalyatsion kuydirgi

Dozalash

- Pnevmoniya: 500 mg 1–2 marta 7–14 kun yoki 750 mg 5 kun
- Sinusit: 500 mg 10–14 kun yoki 750 mg 5 kun
- Siydik yo'llari: 500 mg 7–14 kun yoki 750 mg 5 kun; prostatit: 500 mg 28 kun
- Antatsid, temir, rux, sukralfat — 2 soat oraliq; KK<50 da dozani kamaytirish
- Infuziya og'ir holatda, keyin tabletkaga o'tish

Mumkin emas

Sezuvchanlik; epilepsiya; ftorxinolonlar bilan pay shikastlanishi anamnezi; 18 yoshgacha; homiladorlik va emizish

Nojo'ya ta'sirlar

Uyqusizlik, bosh og'riq, ko'ngil aynishi, diareya; kam — tendinit/pay uzilishi, QT uzayishi, gipoglikemiya, neyropatiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- "Respirator" ftorxinolon: pnevmoniyada keng spektr
- Keksalarda va KS qabul qiluvchilarda pay jarohati xavfi
- Quyoshdan saqlanish

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Taygeron — keng chiqarilish shakllariga ega arzon levofloksatsin»

- Shifokorlar: onkolog, pulmonolog, urolog, xirurg, LOR

O'zingizni tekshiring

Taygeron qaysi preparatlardan 2 soat oraliq bilan ichiladi?
Antatsidlar (Mg, Al), temir, rux, sukralfat, didanozin.

Surunkali bakterial prostatitda Taygeron kursi?
500 mg kuniga 1 marta, 28 kun.

Laen

Linezolid 600 mg

Tabletka

Oksazolidinon antibiotik (J01XX08)

QISQACHA · **600 mg kuniga 2 marta, 10–14 kun (maks. 28 kun). Uzoq davolashda qon tahlili nazorati.**

Ko'rsatmalar

- Nozokomial va shifoxonadan tashqari pnevmoniya (grammusbat qo'zg'atuvchi)
- Teri va yumshoq to'qimalarning asoratli infeksiyalari (grammusbat, shu jumladan MRSA)

Dozalash

- 600 mg kuniga 2 marta (har 12 soatda), odatda 10–14 kun, maks. 28 kun
- Ovqatdan qat'i nazar; v/i dan peroralga o'tishda doza o'zgarmaydi
- Faqat statsionarda, mutaxassis bilan maslahatdan keyin; 18 yoshgacha tavsiya etilmaydi

Mumkin emas

Linezolid/komponentga sezuvchanlik; MAO A yoki B ingibitorlari bilan yoki ulardan 2 hafta ichida; AQB monitoringisiz: nazorat qilinmagan gipertenziya, feoxromotsitoma, karsinoid, tireotoksikoz, bipolyar depressiya, shizoaffektiv buzilish, o'tkir chalkashlik; SSRI, TTsA, triptanlar, simpatomimetiklar, dofaminergik vositalar, petidin, buspiron qabul qilayotganlar; emizish to'xtatiladi

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, diareya, ko'ngil aynishi; MIYELOSUPRESSIYA (>2 hafta — haftalik qon tahlili); neyropatiya (>28 kun), laktatsidoz

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Grammanfiyga ta'sir qilmaydi — aralash infeksiyada kombinatsiya kerak
- O'zi MAO ingibitori: serotoninergik dorilar (masalan Dezestra) bilan xavfli
- Tiraminga boy ovqatlarni ko'p iste'mol qilmaslik

O'zingizni tekshiring

Laen qaysi bakteriyalarga ta'sir qilmaydi?

Grammanfiy bakteriyalarga.

Laen bilan 2 haftadan ortiq davolashda nima nazorat qilinadi?

Qonning umumiy tahlili (trombotsitlar, gemoglobin) — haftalik.

Polimik



Ofloksatsin 200 mg + Ornidazol 500 mg

Tabletka

Kombinatsiyalangan antibakterial (J01RA09)

QISQACHA · **1 tab kuniga 2 marta, 7–10 kun. 16 yoshgacha mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Siydik yo'llari: pielonefrit, prostatit, sistit, epididimit
- Jinsiy yo'l: gonokokk, xlamidiya, trixomonada; ginekologik infeksiyalar
- Ichak: amebiaz, lyamblioz, salmonellyoz, shigellyoz; o'tkir nekrotik yarali gingivit
- Operatsiya oldi/keyingi profilaktika

Dozalash

- Kattalar: 1 tab kuniga 2 marta, 7–10 kun
- Simptomlar ketgach yana kamida 3 kun; 2 oydan ko'p emas
- Chaynamay, suv bilan, ovqatdan oldin yoki keyin

Mumkin emas

Xinolon/komponentga sezuvchanlik; ftorxinolon bilan tendinit anamnezi; epilepsiya va tutqanoq chegarasi pasaygan holatlar; 16 yoshgacha va o'sish davridagi o'smirlar; homiladorlik va laktatsiya; G6FD tanqisligi (gemoliz xavfi)

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh aylanishi, uyqusizlik, qorin og'riq, diareya, ko'ngil aynishi, toshma; kam — QT uzayishi, tendinit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Aerob + anaerob + protozoy — aralash infeksiyalar uchun bitta tabletka
- Quyosh/UV dan saqlanish
- Antatsid, sukralfat, temir, rux — ofloksatsindan 2 soat keyin

O'zingizni tekshiring

Polimik tarkibi?

Ofloksatsin 200 mg + ornidazol 500 mg.

Polimik standart dozasi?

1 tabletka kuniga 2 marta, 7–10 kun.

Orgil



Ornidazol 500 mg

Tabletka

Nitroimidazol, antiprotozoy va antianaerob (G01AF06)

QISQACHA · **Trixomoniaz: 1,5 g bir marta (>60 kg — 2 g). Spirt bilan disulfiramsimon reaksiya bermaydi.**

Ko'rsatmalar

- Trixomoniaz (ayol va erkak)
- Amebiaz (dizenteriya, jigar abssessi)
- Lyamblioz
- Anaerob infeksiyalar; ginekologik va yo'g'on ichak operatsiyalarida profilaktika

Dozalash

- Ovqatdan keyin
- Trixomoniaz: 3 tab bir marta kechqurun (>60 kg: 2 ertalab + 2 kechqurun) yoki 1 tab ×2, 5 kun; sherik ham
- Amebali dizenteriya: shu doza 3 kun; boshqa amebiaz: 1 tab ×2, 5–10 kun
- Lyamblioz: 3 tab (>60 kg: 4) bir marta, 1–2 kun
- Bolalar <35 kg: trixomoniaz 25 mg/kg; lyamblioz/amebiaz 40 mg/kg bir marta

Mumkin emas

> Imidazollarga sezuvchanlik; MNS kasalliklari; qon diskraziyasi

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, qusish, metall ta'mi (~3%); bosh aylanishi, uyquchanlik; kam — tremor, neyropatiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Spirt bilan disulfiramsimon reaksiya BERMAYDI — metronidazoldan asosiy farqi
- Varfarin ta'sirini kuchaytiradi; vekuroniy, litiy bilan ehtiyot

O'zingizni tekshiring

Orgilning metronidazoldan asosiy farqi?

Spirt bilan disulfiramsimon reaksiya bermaydi.

Lyambliozda Orgil dozasi (kattalar)?

3 tabletka (1,5 g) bir marta kechqurun; >60 kg — 4 tabletka; 1–2 kun.

Fizzi



Seknidazol 500 mg

Tabletka

Nitroimidazol, antiprotozoy (P01AB07)

QISQACHA · **Trixomonoz: 2 g bir marta. Davolash davomida va 72 soat keyin spirt mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Urogenital trixomonoz (erkak va ayol)
- Bakterial vaginoz
- Ichak va jigar amebiazi
- Lyamblioz

Dozalash

- Trixomonoz: 4 tab (2 g) BIR MARTA yoki 12 soat oraliq bilan 2 ga bo'lib
- O'tkir ichak amebiazi, lyamblioz: shu sxema
- Simptomsiz sista tashuvchanlik: 1,5 g/sut 3 kun; jigar amebiazi: 1,5 g/sut 5 kun
- Bolalar: 25–30 mg/kg

Mumkin emas

> Nitroimidazollarga sezuvchanlik; homiladorlik I trimestri; organik nevrologik buzilish; qon diskraziyasi anamnezi

Nojo'ya ta'sirlar

Qorin og'riq, ko'ngil aynishi, qusish, diareya; metall ta'mi, glossit, stomatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- T½ ≈ 25 soat — bir martalik davo (hamkorlik oson)
- Davolash davomida va 72 soat keyin spirt mumkin emas
- Homilador va emizikli ayollarga qo'llanmaydi

O'zingizni tekshiring

Trixomonozda Fizzi dozasi?

2 g (4 tabletka) bir marta.

Fizzi bilan spirt qachongacha mumkin emas?

Davolash davomida va tugagach 72 soat.

Fusis



Flukonazol

Tab. 50/100/150/200 mg; Fusis DT 50 mg (bolalar); infuziya 200 mg/100 ml

Tizimli antimikotik, triazol (J02AC01)

QISQACHA · **O'tkir vaginal kandidoz: 150 mg bir marta. Tabletka 6 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Vaginal kandidoz (o'tkir va qaytalanuvchi), kandidozli balanit
- Shilliq qavat kandidozi: og'iz-tomoq, qizilo'ngach, kandiduriya; invaziv kandidoz
- Kriptokokk meningiti, koksidioidomikoz
- Dermatomikozlar, rangli temiratki, onixomikoz; immunosupressiyada profilaktika

Dozalash

- O'tkir vaginal kandidoz/balanit: 150 mg BIR MARTA
- Qaytalanuvchi: 150 mg 1-, 4-, 7-kunlari, keyin haftasiga 150 mg 6 oy
- Og'iz-tomoq: 1-kun 200–400 mg, keyin 100–200 mg 7–21 kun
- Dermatomikoz: 150 mg haftada 1 marta 2–4 hafta; onixomikoz: 150 mg haftada 1 marta tirnoq o'sguncha
- Bolalar (DT): 3 mg/kg (shilliq), 6–12 mg/kg (invaziv)

Mumkin emas

Flukonazol/azollarga sezuvchanlik; 400 mg+ dozada terfenadin bilan; sizaprid, astemizol, pimozid, xinidin, eritromitsin bilan (QT); tabletkalar 6 yoshgacha mumkin emas (bolalarga — Fusis DT); DT: homiladorlik, emizish

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, qorin og'riq, diareya, ko'ngil aynishi, toshma, jigar fermentlari oshishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- T½ ≈ 30 soat — haftada 1 marta qabul mumkin
- DT — suvda eriydi, bolalar uchun qulay; infuziya — og'ir holatlar uchun
- Varfarin va sulfonilmochevina ta'sirini kuchaytiradi

O'zingizni tekshiring

O'tkir vaginal kandidozda Fusis dozasi?

150 mg bir marta.

Qaytalanuvchi vaginal kandidozda Fusis sxemasi?

150 mg 1-, 4-, 7-kunlari, keyin 6 oy haftasiga 150 mg.

Eszol



Itrakonazol 100 mg

Tabletka

Tizimli antimikotik (J02AC02)

QISQACHA · **Ovqatdan keyin darhol. Vulvovaginal kandidoz: 200 mg kuniga 2 marta, 1 kun.**

Ko'rsatmalar

- Vulvovaginal kandidoz; kepaksimon temiratki; dermatomikozlar; orofaringeal kandidoz
- Onixomikoz
- Gistoplazmoz; tizimli mikozlar (aspergillyoz, kandidoz, kriptokokkoz)

Dozalash

- Ovqatdan keyin darhol, butun yutiladi
- Vulvovaginal kandidoz: 200 mg ×2, 1 kun
- Kepaksimon temiratki: 200 mg ×1, 7 kun
- Tana/chov: 100 mg 15 kun yoki 200 mg 7 kun; oyoq/kaft: 100 mg 30 kun
- Onixomikoz: 200 mg kuniga 1 marta 3 oy

Mumkin emas

Itrakonazolga sezuvchanlik; CYP3A4 substratlari bilan birga (yo'riqnoma jadvali: metadon, dizopiramid, dofetilid, dronedaron, xinidin, galofantrin, astemizol, mizolastin, terfenadin, ergot alkaloidlari, irinotekan va b.)

Nojo'ya ta'sirlar

Tez-tez: bosh og'riq, qorin og'riq, ko'ngil aynishi; tez-tez emas: dispepsiya, qabziyat, meteorizm, diareya, qusish, jigar funksiyasi buzilishi, toshma, qichishish; kam: og'ir gepatotoksiklik, turg'un yurak yetishmovchiligi, eshitish yo'qolishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Kislotalikni kamaytiruvchilar so'rilishni kamaytiradi — nordon ichimlik bilan
- Teri infeksiyasida samara kursdan 1–4 hafta keyin, tirnoqda 6–9 oy keyin ko'rinadi
- Bolalarga tavsiya etilmaydi

O'zingizni tekshiring

Eszol qanday ichiladi?

Ovqatdan keyin darhol, butunligicha.

Onixomikozda Eszol sxemasi?

200 mg kuniga 1 marta, 3 oy.

Infeksiyalar va parazitlar

Albela

Albendazol 400 mg

Tabletka (apelsin ta'mi)

Gelmintga qarshi, benzimidazol (P02CA03)



QISQACHA · **Askaridoz, enterobioz va b.: 400 mg bir marta. 3 yoshdan. Homiladorlikda mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Ichak gelmintozlari: enterobioz, askaridoz, ankilostomoz, trixotsefalyoz, strongiloidoz, tenioz, gimenolepidoz, opistorxoz
- Teri Larva migrans; bolalarda lyamblioz
- Tizimli: exinokokkoz, neyrotsistitserkoz, toksokaroz, trixinellyoz

Dozalash

- Ovqat bilan; kattalar va 3 yoshdan
- Enterobioz, askaridoz, ankilostomoz, trixotsefalyoz: 400 mg BIR MARTA
- Strongiloidoz, tenioz, gimenolepidoz: 400 mg 3 kun
- Opistorxoz, klonorxoz: 400 mg ×2, 3 kun; lyamblioz (3–12 yosh): 400 mg 5 kun
- Tizimli (6 yoshdan): >60 kg 400 mg ×2; <60 kg 15 mg/kg/sut

Mumkin emas

> Albendazol yoki komponentga sezuvchanlik; homiladorlik va emizish; homiladorlikni rejalashtirayotgan ayollar (davolash davomida va 1 oy keyin nogormonal kontratsepsiya)

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, bosh aylanishi, epigastral og'riq, ko'ngil aynishi, qusish, diareya, jigar fermentlari oshishi, alopesiya, isitma; kam — leykopeniya, gepatit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Keng spektr: tuxum, lichinka va yetuk shakllarga
- 3 haftada tuzalmasa — 2-kurs
- Yog'li ovqat tizimli so'rilishni oshiradi

O'zingizni tekshiring

Askaridozda Albela dozasi?

400 mg bir marta.

Albela qaysi yoshdan?

3 yoshdan.

Pirantel



Pirantel pamoat 250 mg

Tabletka

Gelmintga qarshi (P02CC01)

QISQACHA · **10 mg/kg bir marta. Enterobiozda 3 haftadan keyin takrorlanadi.**

Ko'rsatmalar

- Askaridoz, enterobioz, ankilostomoz, nekatoroz, trixostrongilez

Dozalash

- 10 mg/kg bir marta, istalgan vaqtda; surgi shart emas; yaxshilab chaynash
- 3–6 yosh: 1 tab; 6–12 yosh: 2 tab; 12 yoshdan (<75 kg): 3 tab; >75 kg: 4 tab
- Enterobiozda 3 haftadan keyin takrorlash, butun oila davolanadi
- Ankilostomoz: 10 mg/kg 3 kun yoki 20 mg/kg 2 kun

Mumkin emas

Sezuvchanlik; jigar yetishmovchiligi; miasteniya

Nojo'ya ta'sirlar

Epigastral og'riq, ko'ngil aynishi, diareya, bosh aylanishi, uyquchanlik, toshma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- PIPERAZIN bilan birga mumkin emas (antagonizm)
- Levamizol toksikligini oshiradi; teofillin darajasini oshiradi

O'zingizni tekshiring

Pirantel qaysi dori bilan mumkin emas?

Piperazin bilan (antagonizm).

Enterobiozda Pirantel bilan qanday qoida?

3 haftadan keyin takrorlash va butun oilani bir vaqtda davolash.

Gastroenterologiya

7 ta preparat

Zolopent
Domrid
Loflatil
Ukrliv
Sogelen
Ezetum 10000
Flyut Astezin

Zolopent

Pantoprazol 40 mg

Ichakda eruvchan tabletka

Proton pompasi ingibitori (A02BC02)



QISQACHA · 40 mg ovqatdan 1 soat oldin. H. pylori: 40 mg ×2 + ikki antibiotik, 7 kun.

Ko'rsatmalar

- Reflyuks-ezofagit (kattalar va 12 yoshdan)
- Me'da va o'n ikki barmoq ichak yarasi
- H. pylori eradikatsiyasi (antibiotiklar bilan)
- Zollinger-Ellison sindromi

Dozalash

- Ovqatdan 1 soat oldin, chaynamay
- Reflyuks-ezofagit: 40 mg/sut 4 hafta (+4); me'da yarasi: 40 mg 4–8 hafta; 12-barmoq: 40 mg 2–4 hafta
- H. pylori (7 kun): 40 mg ×2 + amoksitsillin 1 g ×2 + klaritromitsin 500 mg ×2 (yoki metronidazol bilan)
- Zollinger-Ellison: 80 mg/sut dan; og'ir jigar — maks. 20 mg/sut

Mumkin emas

> Pantoprazol, benzimidazol hosilalari yoki komponentga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Tez-tez: me'da tubi bez poliplari (xavfsiz); tez-tez emas: diareya, ko'ngil aynishi, qusish, qorin shishi, qabziyat, og'iz qurishi, qorin og'riq, bosh og'riq, bosh aylanishi, uyqu buzilishi, jigar fermentlari oshishi, toshma; noma'lum: gipomagniemiya; suyak sinishi xavfi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Buyrak buzilishida doza o'zgarmaydi
- Atazanavir bilan birga tavsiya etilmaydi; varfarin bilan XNN nazorati; yuqori dozali metotreksat bilan ehtiyot
- Ziomitsin yoki Orgil bilan eradikatsiya sxemalarida o'rin bor

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Zolopent — Kontrolokka 98,5% bioekvivalent pantoprazol / Me'da shirasi kislotaligini me'yorda ushla!»

O'zingizni tekshiring

Zolopent qachon ichiladi?

Ovqatdan 1 soat oldin, chaynamasdan.

Reflyuks-ezofagitda Zolopent kursi?

40 mg/sut 4 hafta, kerak bo'lsa yana 4 hafta.

Domrid

Domperidon

Tabletka 10 mg; suspenziya 1 mg/ml 60/100 ml

Prokinetik, qusishga qarshi (A03FA03)

QISQACHA · **10 mg kuniga 3 marta, maks. 30 mg/sut, 1 haftagacha. Yurak kasalligi va QT uzayishida mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Ko'ngil aynishi va qusish simptomlarini yengillatish

Dozalash

- Kattalar va 12 yoshdan, ≥35 kg: 10 mg (1 tab yoki 10 ml) kuniga 3 marta; maks. 30 mg/sut
- Suspenziya, <35 kg: 0,25 mg/kg kuniga 3 marta; maks. 0,75 mg/kg/sut
- Ovqatdan oldin; davolash 1 HAFTADAN oshmasin

Mumkin emas

Sezuvchanlik; prolaktinoma; o'rta yoki og'ir JIGAR va/yoki BUYRAK buzilishi; QT uzayishi, elektrolit buzilishi, yurak yetishmovchiligi; GI qon ketish, obstruksiya, perforatsiya; kuchli CYP3A4 ingibitorlari va QT uzaytiruvchilar bilan (ketokonazol, eritromitsin, flukonazol, itrakonazol, klaritromitsin, amiodaron va b.)

Nojo'ya ta'sirlar

Prolaktin oshishi (galaktoreya, ginekomastiya), og'iz qurishi, bosh og'riq; kam — QT uzayishi, qorincha aritmiyasi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Periferik ta'sir — ekstrapiramidal NT kam (bolalarda dozani oshirmaslik)
- Ketokonazol, klaritromitsin bilan birga emas

O'zingizni tekshiring

Domridning maksimal sutkalik dozasi va muddati?

30 mg/sut, davolash 1 haftadan oshmaydi.

Domrid tabletkasi qaysi bolalarga mumkin?

12 yoshdan va tana vazni kamida 35 kg bo'lganlarga.

Loflatil



Loperamid 2 mg + Simetikon 125 mg

Tabletka

Diareyaga qarshi + ko'pikni so'ndiruvchi (A07DA53)

QISQACHA · **Boshida 2 tab, keyin har suyuq ichdan keyin 1 tab; maks. 4 tab/sut, 2 kun. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Kattalar va 12 yoshdan o'tkir diareya, qorinda gaz to'planishi (meteorizm, spazm, shish) bilan

Dozalash

- Boshida 2 tab, keyin har suyuq ichdan keyin 1 tab
- Maks. 4 tab/sut; 2 kundan oshmasin
- 12 yoshgacha mumkin emas

Mumkin emas

12 yoshgacha; qonli axlat va isitmali dizenteriya; o'tkir yarali kolit; psevdomembranoz kolit; Salmonella/Shigella/Campylobacter enterokoliti; qabziyat, ichak tutilishi, megakolon

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi; bosh og'riq, qabziyat, meteorizm, og'iz qurishi; kam — ichak tutilishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Ikki muammo bitta tabletkada: diareya + shishish
- Qabziyat yoki qorin shishsa — darhol to'xtatish

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Loflatil — O'zbekistonda yagona loperamid + simetikon; diareya va qorin dam bo'lishini tez bartaraf etadi»

- Gastroenterologlar: noinfeksion diareyada

O'zingizni tekshiring

Loflatil qanday ichiladi?

Boshida 2 tabletka, keyin har suyuq ichdan keyin 1 tabletka; maks. 4 tab/sut, 2 kun.

Loflatil qaysi diareyada mumkin emas?

Qonli va isitmali (dizenteriya), bakterial enterokolit, psevdomembranoz kolit, o'tkir yarali kolit.

Ukrliv



Ursodezoksixol kislota 250 mg

Tabletka

Gepatoprotektor, o't toshini erituvchi (A05AA02)

QISQACHA · **~10 mg/kg kechqurun, 6–24 oy. Faqat xolesterin (rentgen-negativ) toshlar.**

Ko'rsatmalar

- Diametri ≤15 mm rentgen-negativ xolesterin toshlarini eritish (o't pufagi funksiyasi saqlangan)
- Dekompensatsiyalanmagan birlamchi biliar sirroz
- 6 yoshdan mukovistsidozdagi gepatobiliar kasalliklar

Dozalash

- Tosh eritish: ~10 mg/kg KECHQURUN: <60 kg 2 tab; 61–80 kg 3; 81–100 kg 4; >100 kg 5 tab
- Kurs 6–24 oy; 12 oyda kichraymasa to'xtatish; har 6 oyda UZI
- Birlamchi biliar sirroz: 14±2 mg/kg/sut
- Mukovistsidoz: 20 mg/kg/sut 2–3 ga bo'lib (30 mg/kg gacha)

Mumkin emas

Sezuvchanlik; o't pufagi/yo'llarining o'tkir yallig'lanishi; o't yo'llari obstruksiyasi; tez-tez biliar kolika; o't pufagi qisqarishi buzilishi; rentgen-kontrast kalsiylashgan toshlar; dekompensatsiyalangan sirroz; bolalarda muvaffaqiyatsiz portoenterostomiya/o't yo'li atreziyasi

Nojo'ya ta'sirlar

Bo'tqasimon axlat, diareya, o'ng qovurg'a ostida og'riq; tosh kalsiylashishi; sirroz dekompensatsiyasi; eshakemi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Faqat XOLESTERIN (rentgen-negativ) toshlarni eritadi
- Xolestiramin, kolestipol, Al-antatsidlar, smektit — 2 soat oraliq; siklosporin so'rilishini oshiradi, siprofloksatsinnikini kamaytiradi
- Nazorat: AST, ALT, GGT dastlabki 3 oy har 4 haftada; toshda 6–10 oyda UZI

O'zingizni tekshiring

Ukrliv qanday toshlarni eritadi?

Diametri 15 mm gacha bo'lgan rentgen-negativ xolesterin toshlarini.

Tosh eritishda Ukrliv qachon ichiladi?

Kechqurun uxlashdan oldin, kuniga 1 marta (~10 mg/kg).

Sogelen

Mesalazin 1000 mg

Rektal suppozitoriy

Aminosalitsilat (A07EC02)



QISQACHA · 1 g sham kuniga 1 marta kechqurun (yarali proktit).

Ko'rsatmalar

- To'g'ri ichak bilan chegaralangan yengil va o'rta og'ir o'tkir yarali kolit (yarali proktit)

Dozalash

- 1 supp (1 g) kuniga 1 marta rektal, kechqurun uxlashdan oldin
- Muntazam qo'llash; davomiyligi vrach belgilaydi

Mumkin emas

Salitsilatlarga sezuvchanlik; og'ir jigar yoki buyrak buzilishi

Nojo'ya ta'sirlar

Kam (~3%): bosh og'riq, qorin og'riq, diareya, ko'ngil aynishi; juda kam — perikardit, pankreatit, nefrit

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Mahalliy ta'sir yallig'lanish o'chog'ida
- Qon, jigar, kreatinin, siydik tahlili — oldin va davomida
- Azatioprin, 6-merkaptopurin bilan miyelosupressiya xavfi

O'zingizni tekshiring

Sogelenning ko'rsatmasi?

To'g'ri ichak bilan chegaralangan yengil-o'rta o'tkir yarali kolit (proktit).

Sogelen qachon yuboriladi?

Kuniga 1 marta kechqurun, uxlashdan oldin.

Ezetum 10000



Pankreatin 150 mg (lipaza 10 000 TB, amilaza 8000 TB, proteaza 600 TB)

Kapsula (ichakda eriydigan minimikrosferalar), 20 (2×10) yoki 100 (10×10)

Poliferment preparat (A09AA02)

QISQACHA · **Ovqat bilan 1–2 kapsula; granulalar chaynalmaydi.**

Ko'rsatmalar

- Oshqozon osti bezining ekzokrin yetishmovchiligi

Dozalash

- Kattalar, keksalar va bolalar: ovqat boshida yoki ovqatdan keyin darhol 1–2 kapsula
- Kerak bo'lsa doza asta oshiriladi
- Butun yutiladi yoki ochib, granulalar nordon ovqat/sharbat (olma pyuresi, yogurt) bilan, CHAYNAMASDAN
- Yetarli suyuqlik ichish

Mumkin emas

> Komponentlarga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Qorin og'riq (juda tez-tez); ko'ngil aynishi, qusish, qabziyat, qorin shishi, diareya; kam — toshma, allergiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Minimikrosferalar me'dada ovqat bilan bir tekis aralashadi, ichakda faollashadi
- Mukovistsidozda >10 000 TB lipaza/kg/sut — fibrozlanuvchi kolonopatiya xavfi
- Retseptsiz

O'zingizni tekshiring

Ezetum qachon ichiladi?

Ovqat boshida yoki ovqatdan keyin darhol, 1–2 kapsula.

Kapsulani yuta olmaydigan bemorga nima deyiladi?

Kapsulani ochib, granulalarni nordon yumshoq ovqat bilan chaynamasdan yutish.

Flyut Astezin



Benzokain 206 mg

Rektal suppozitoriy, 6 yoki 12 (2×6)

Mahalliy anestetik — gemorroy va anal yoriqlar uchun (C05AD03)

QISQACHA · **1 sham ertalab va kechqurun; maks. 4 sham/sut. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Tashqi va ichki gemorroy
- Anus yoriqlari, eroziyalar, mikrojarohatlar; og'riq va perianal qichishish
- Proktologik operatsiyadan keyingi og'riq

Dozalash

- Gigiyenik muolajadan keyin: ertalab defekatsiyadan keyin va kechqurun uxlashdan oldin 1 supp
- Maks. 4 supp/sut
- Odatda 1 hafta, zarur bo'lsa 3 haftagacha (vrach bilan)

Mumkin emas

O'ta sezuvchanlik; tromboembolik kasallik; granulotsitopeniya; 12 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Kam: kontakt dermatit, giperemiya, qichishish; juda kam (yuqori doza) — metgemoglobinemiya (lab va tirnoq ko'karishi, hansirash)

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- MAO ingibitorlari, antidepressantlar, gipotenziv dorilar bilan tavsiya etilmaydi
- 7 kundan ortiq qon aralash ajralma bo'lsa — proktologga
- Retseptsiz

O'zingizni tekshiring

Flyut Astezinning maksimal sutkalik dozasi?

4 suppozitoriy.

Benzokainning kam uchraydigan xavfli nojo'ya ta'siri?

Metgemoglobinemiya (teri, lab, tirnoq ko'karishi, hansirash, taxikardiya).

Pulmonologiya, LOR va allergiya

7 ta preparat

Montular / Montular Kids

Mukeks

L-Set

Gripgo

Gripgo Xotmiks

Askozin Maks

Askotsin

Montular / Montular Kids



Montelukast

Tab. 10 mg; Kids — chaynaladigan tab. 4 mg / 5 mg

Leykotrien retseptor antagonisti (R03DC03)

QISQACHA · **Kuniga 1 marta kechqurun: 2–5 yosh 4 mg, 6–14 yosh 5 mg, 15 yoshdan 10 mg.**

Ko'rsatmalar

- Yengil-o'rta persistent bronxial astma — ingalyatsion KS ga qo'shimcha
- Astmali bemorlarda mavsumiy allergik rinit
- Jismoniy yuklama bronxospazmi profilaktikasi

Dozalash

- Kuniga 1 marta KECHQURUN
- 2–5 yosh: 4 mg; 6–14 yosh: 5 mg; 15 yoshdan: 10 mg
- Kids: ovqatdan 1 soat oldin yoki 2 soat keyin, chaynab

Mumkin emas

> Montelukastga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Bosh og'riq, qorin og'riq; kam — uyqu buzilishi, qo'rqinchli tushlar, kayfiyat o'zgarishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- O'tkir astma xurujini to'xtatish uchun EMAS
- Ingalyatsion KS ni birdaniga almashtirmaslik
- Kids tabletkasida aspartam — fenilketonuriyada ehtiyot

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Montular — bronxial astma va allergik rinitni bazis davolash»

O'zingizni tekshiring

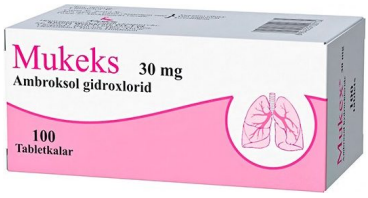
6 yoshli bolaga Montularning qaysi dozasi?

5 mg chaynaladigan tabletka kuniga 1 marta kechqurun.

Montular o'tkir astma xurujida ishlatiladimi?

Yo'q, faqat nazorat va profilaktika uchun.

Mukeks





Ambroksol

Sirop 15 mg/5 ml va 30 mg/5 ml; tabletka 30 mg

Mukolitik, balg'am ko'chiruvchi (R05CB06)

QISQACHA · **Kattalar: 30 mg kuniga 3 marta (2–3 kun), keyin 2 marta.**

Ko'rsatmalar

- Bronx sekretsiyasi buzilishi bilan o'tkir va surunkali bronxo-o'pka kasalliklari — sekretolitik terapiya

Dozalash

- Tabletka (12 yoshdan): 1 tab ×3 (90 mg); kuchaytirish — 2 tab ×2 (120 mg)
- Sirop 15 mg/5 ml: <2 yosh 2,5 ml ×2; 2–5 yosh 2,5 ml ×3; 6–12 yosh 5 ml ×2–3; 12+ 10 ml ×3 (2–3 kun), keyin ×2
- Sirop 30 mg/5 ml: 6–12 yosh 2,5 ml ×3; 12+ 5 ml ×3, keyin ×2
- Vrachsiz 4–5 kundan ko'p emas; ko'p suyuqlik ichish

Mumkin emas

Ambroksolga sezuvchanlik; yordamchi moddalarga irsiy intoleransi; tabletka 12 yoshgacha mumkin emas

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, ta'm o'zgarishi, og'iz/tomoq sezuvchanligi pasayishi; kam — toshma, juda kam — og'ir teri reaksiyalari

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Siropda: amoksitsillin, sefuroksim, eritromitsin, doksitsiklin ning balg'amdagi konsentratsiyasini oshiradi
- Siropi alkogolsiz, diabetda mumkin (o'rik ta'mi)
- Homiladorlik (ayniqsa I trimestr) va emizishda tavsiya etilmaydi

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Mukeks — kattalar va tug'ilgandan boshlab bolalarda nam yo'talni samarali davolash»

⚠ 2 yoshgacha yo'riqnomada faqat vrach buyurganda.

O'zingizni tekshiring

Mukeks antibiotiklar bilan qanday ta'sirlashadi?

Amoksitsillin, sefuroksim, eritromitsin, doksitsiklinning bronx sekretidagi konsentratsiyasini oshiradi.

Kattalarga Mukeks tabletka dozasi?

30 mg kuniga 3 marta; kuchaytirish uchun 60 mg kuniga 2 marta.

L-Set



Levotsetirizin 5 mg

Tabletka

Antigistamin, II avlod (R06AE09)

QISQACHA · 5 mg kuniga 1 marta, 6 yoshdan. Buyrak buzilishida qabul oralig'i uzaytiriladi.

Ko'rsatmalar

- Allergik rinit (shu jumladan yil bo'yi davom etadigan)
- Eshakemi

Dozalash

- Kattalar va 6 yoshdan: 5 mg kuniga 1 marta, ovqatdan qat'i nazar
- Buyrak KK 30–49: har 2 kunda; <30: har 3 kunda; <10: mumkin emas

Mumkin emas

Levotsetirizin, setirizin, gidroksizin va boshqa piperazinlarga sezuvchanlik; og'ir buyrak yetishmovchiligi (KK <10 ml/daq)

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik (5,2%), bosh og'riq (2,6%), og'iz qurishi (2,6%), holsizlik (2,5%); to'xtatgandan keyin qichishish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Setirizinning faol enantiomeri — kichik dozada samarali
- Kuniga 1 marta qulay

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«L-Set — allergiyaning barcha turlari uchun so'nggi avlod antigistamin, sedatsiyasiz»

O'zingizni tekshiring

L-Set qaysi yoshdan?

6 yoshdan.

KK 30–49 bo'lsa L-Set qanday beriladi?

5 mg har 2 kunda 1 marta.

Gripgo



Paratsetamol 500 + Kofein 30 + Fenilefrin 10 + Xlorfeniramin 2 mg

Tabletka

ORVI simptomlarini yengillatuvchi kombinatsiya (N02BE51)

QISQACHA · **1 tab kuniga 3–4 marta, maks. 4 tab/sut. Gipertenziya va glaukomada mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Shamollash, gripp, sinusit: burun bitishi, rinit, isitma, bosh og'riq, aksirish

Dozalash

- Kattalar: 1 tab kuniga 3–4 marta; maks. 4 tab/sut
- 12 yoshgacha mumkin emas
- Paratsetamolli boshqa dorilar bilan birga emas

Mumkin emas

Boshqa simpatomimetik dekongestantlar; feoxromotsitoma; yopiq burchakli glaukoma; homiladorlik, emizish; og'ir jigar/buyrak; gipertenziya, gipertireoz, diabet, yurak kasalligi; TTsA, beta-blokatorlar, MAO ingibitorlari

Nojo'ya ta'sirlar

Uyquchanlik, og'iz qurishi, AQB oshishi, taxikardiya, asabiylik, siydik tutilishi

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- 4 komponent: isitma/og'riq + energiya + burun + allergiya
- Xlorfeniramin uyquchanlik beradi — haydovchilarni ogohlantirish

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Gripp kuchli — Gripgo kuchliroq!»

O'zingizni tekshiring

Gripgo tarkibi?

Paratsetamol 500 mg, kofein 30 mg, fenilefrin 10 mg, xlorfeniramin 2 mg.

Gripgo kimga mumkin emas?

Gipertenziya, yurak kasalligi, glaukoma, diabet, gipertireoz, homiladorlik, 12 yoshgacha va b.

Gripgo Xotmiks



Paratsetamol 750 + Askorbin kislota 60 + Fenilefrin 10 mg

Granula, sashe 5 g (limon / qulupnay / qora smorodina)

ORVI simptomlarini yengillatuvchi issiq ichimlik (N02BE51)

QISQACHA · **1 sashe issiq suvda har 6–8 soatda, maks. 4 sashe/sut. 12 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Shamollash va gripp: bosh og'riq, isitma, tumov, sinusit, tomoq og'rig'i, tana qaqshashi

Dozalash

- 12 yoshdan: 1 sashe har 6–8 soatda, oraliq kamida 6 soat; maks. 4 sashe/sut
- Yarim stakan issiq suvda eritib ichiladi
- Vrachsiz maks. 7 kun

Mumkin emas

Og'ir jigar/buyrak; G6FD tanqisligi; fruktoza/saxaroza intoleransi; alkogolizm; og'ir gipertenziya, yurak kasalliklari; glaukoma; diabet; tireotoksikoz; feoxromotsitoma; prostata giperplaziyasi; homiladorlik, emizish; MAO ingibitorlari

Nojo'ya ta'sirlar

Toshma, bosh og'riq, asabiylik, uyqusizlik, ko'ngil aynishi, AQB oshishi, taxikardiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Gripgo tabletkadan farqi: paratsetamol 750 mg + vitamin C; xlorfeniramin va kofein YO'Q — uyquchanlik bermaydi
- 3 xil ta'm — bir preparat

O'zingizni tekshiring

Gripgo Xotmiksning Gripgo tabletkadan farqi?

Paratsetamol 750 mg va vitamin C bor; xlorfeniramin va kofein yo'q.

Gripgo Xotmiks maksimal sutkalik dozasi?

4 sashe, oraliq kamida 6 soat.

Askozin Maks



Vitamin C 1000 mg + Rux 10 mg

Shipuchi tabletka (apelsin)

Vitamin C va rux (A11GB)

QISQACHA · **1 tab kuniga 1 marta, 12 yoshdan. Buyrak toshida mumkin emas.**

Ko'rsatmalar

- Vitamin C va rux tanqisligini davolash

Dozalash

- Kattalar va 12 yoshdan: 1 tab kuniga 1 marta, 200 ml suvda eritib

Mumkin emas

Buyrak toshi (hozir yoki anamnezda), oksaluriya; og'ir buyrak yetishmovchiligi, dializ; gemoxromatoz; sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Diareya, ko'ngil aynishi, qorin og'riq; allergik reaksiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Rux tetratsiklin va xinolonlar so'rilishini kamaytiradi — 2 soat oldin yoki 4–6 soat keyin
- Aspartam — fenilketonuriyada ehtiyot
- Varfarin samarasini kamaytirishi mumkin

O'zingizni tekshiring

Askozin Maks kimga mumkin emas?

Buyrak toshi/oksaluriya, og'ir buyrak yetishmovchiligi, gemoxromatoz.

Askozin Maks antibiotiklar bilan qanday ichiladi?

Tetratsiklin/xinolonlardan 2 soat oldin yoki 4–6 soat keyin.

Askotsin



Vitamin C 500 mg (askorbin kislota 100 mg + natriy askorbat) + Rux 15 mg

Chaynaladigan tabletka, №100 (10×10)

Vitamin C va rux (A11GB)

QISQACHA · **Chaynaladigan tabletka: kattalar 1 tab kuniga 1 marta. 6 yoshdan.**

Ko'rsatmalar

- Shamollash, infeksiyalar va immun tanqisligiga moyillik
- C gipo- va avitaminozi; uzoq bitmaydigan yaralar, sinishlar
- Teri, soch, tirnoq, tomir mo'rtligi — kompleks davo

Dozalash

- Ovqatdan keyin, chaynab, suv bilan
- Kattalar: 1 tab kuniga 1 marta; yaqqol avitaminoz va infeksiyada qisqa muddat (5–7 kun) 1 tab ×2
- Bolalar: 6–8 yosh 1 tab/sut; 8–18 yosh ko'pi bilan 2 tab/sut

Mumkin emas

O'ta sezuvchanlik; tromboflebit, trombozga moyillik; 6 yoshgacha

Nojo'ya ta'sirlar

Ko'ngil aynishi, qusish, zarda, diareya; bosh og'riq; buyrak toshi; allergik reaksiya

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Askozin Maks (shipuchi, 1000 mg + 10 mg) dan farqi: chaynaladigan, 500 mg + 15 mg rux
- Buyrak toshi, G6FD tanqisligi, gemoxromatozda ehtiyot
- Tetratsiklin, xinolonlar va temir bilan o'zaro ta'sir

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Askotsin — immunitetni faollashtirish uchun! / Ayollar va erkaklar reproduktiv salomatligi uchun hamyonbop rux!»

- 500 mg C + 15 mg rux — dunyoda mashhur kombinatsiya, komponentlar bir-birini kuchaytiradi

O'zingizni tekshiring

Askotsin bilan Askozin Maks farqi?

Askotsin — chaynaladigan, vitamin C 500 mg + rux 15 mg; Askozin Maks — shipuchi, 1000 mg + 10 mg.

Askotsin qaysi yoshdan?

6 yoshdan.

Ilovalar

Kompaniya bergan qo'shimcha materiallar

A. Ilmiy maqolalar qisqacha (16 ta)

B. Atamalar lug'ati

MAQOLA · Rekol

Memantin: psixiatriyada qo'llash imkoniyatlari (sharh)

Bekker R.A., Bykov Yu.V., 2018

Nima o'rganilgan: Memantinning turli ruhiy kasalliklarda qo'llanishi bo'yicha adabiyot sharhi.

Natija: Altsgeymer — A+ dalil (FDA ko'rsatmasi); frontotemporal va nurlanish demensiyasi — A; tomir/postinsult demensiyasi — B; boshqa holatlarda dalillar turlicha.

Vrachga qanday aytish: "Memantin faqat Altsgeymerda emas — tomir demensiyasida ham dalillar bor (B daraja)."

MAQOLA · Rekol

Demensiyalarda eksaytotoksiklik fenomeni farmakologik ta'sir obyekti sifatida

Burchinskiy S.G., Gerontologiya instituti (Kiyev)

Nima o'rganilgan: Memantinning demensiya davosidagi o'rni.

Natija: Memantin barcha shakl va bosqichlardagi demensiyada samarali: kognitiv, xulq va psixoemotsional sindromlarga ta'sir, uzoq ta'sir, kombinatsiyaga mos, yaxshi o'zlashtiriladi.

Vrachga qanday aytish: "Glutamat 'korrektori' — kognitiv va xulq simptomlariga birga ta'sir qiladi."

MAQOLA · Rekol

Parkinson kasalligi va demensiyada memantin samaradorligi

Levin O.S., Batukayeva L.A.

Nima o'rganilgan: 15 bemor, 24 hafta; doza 5→10→15→20 mg; nazorat guruhi bilan.

Natija: Psixik holatning barqaror yaxshilanishi va yaxshi o'zlashtirilishi; samara Altsgeymerdagiga yaqin. Davolanganlarning 86% i tadqiqotni yakunlagan.

Vrachga qanday aytish: "Parkinsondagi demensiyada ham Rekol — Konfundus/Pramisum bilan birga."

MAQOLA · Rekol

Postinsult nutq buzilishlarini korreksiyalash (klinik holat)

Koberskaya N.N., 2016

Nima o'rganilgan: Ikki marta kardioembolik insult o'tkazgan bemorda memantin 20 mg + logoped.

Natija: Nutq buzilishlari o'rtacha, xotira va boshqaruv defekti sezilarli kamaygan.

Vrachga qanday aytish: Bitta klinik holat — kuchli dalil emas; "reabilitatsiyada qo'shimcha imkoniyat" sifatida.

MAQOLA · Rekol + Rosemid

Autizm spektri buzilishlarida kichik dozada risperidon va memantin (bolalar)

Kalinina M.A. va b., Ruhiy salomatlik ilmiy markazi (Moskva), 2016

Nima o'rganilgan: 6–16 yoshli bolalarda neyroleptik fonida memantin.

Natija: Neyroprotektiv ta'sir; xavfsiz samarali doza kichik — 1,5–2,5 mg/sut; yuqori dozalar nojo'ya ta'sir berishi mumkin.

Vrachga qanday aytish: Faqat psixiatr uchun; bolalar dozasi yo'riqnomada yo'q — tavsiya sifatida aytmang.

MAQOLA · Rekol

Bolalarda autizm spektri buzilishlarining dori bilan davosi (xorijiy tajriba)

Borodina L.G., 2012

Nima o'rganilgan: Autizmdagi dori davolari sharhi.

Natija: Bitta manbaga ko'ra memantin nutqni 70%, ijtimoiy xulqni 71% hollarda yaxshilagan; mexanizm noaniq.

Vrachga qanday aytish: Sharh maqola — faqat ma'lumot uchun.

MAQOLA · Kvanil

Distsirkulyator ensefalopatiyada neyrometabolik korreksiya

Kuznetsova S.M., Yegorova M.S., 2016

Nima o'rganilgan: 30 bemor, aterosklerotik ensefalopatiya 1–2 bosqich; Kvanil 500 mg kuniga 2 marta kurs.

Natija: Diqqat, qisqa va uzoq muddatli xotira yaxshilangan, xavotir kamaygan; EEG ijobiy o'zgargan.

Vrachga qanday aytish: "Surunkali ishemiyada ham Kvanil — xotira va kayfiyatni yaxshilaydi."

MAQOLA · Oksapin

Karbamazepin o'rniga Oksapin: fokal epilepsiyada samaradorlik

Dubenko A.Ye., Vasilyeva O.A., Nevrologiya instituti (Xarkov)

Nima o'rganilgan: 27 bemor (18–47 yosh), karbamazepin samarasiz bo'lganlar; 600–1200 mg/sut, 90 kun.

Natija: Mono- va kombinatsiyada yetarli samara; 90 kun davomida nojo'ya reaksiyalar kuzatilmagan.

Vrachga qanday aytish: "Karbamazepin yordam bermasa — Oksapinga o'tkazing."

MAQOLA · Oksapin

Okskarbazepin — bolalar epileptologiyasida yangi imkoniyatlar

Stetsenko T.I., Shupik akademiyasi (Kiyev)

Nima o'rganilgan: Okskarbazepin bo'yicha sharh, hayot sifati tadqiqotlari.

Natija: Monoterapiya hayot sifatini ishonchli yaxshilaydi (QOLIE-31, p<0,0001); Oksapin farmakokinetikasi originalga yaqin.

Vrachga qanday aytish: "6 yoshdan bolalarga — hayot sifatini yaxshilaydi."

MAQOLA · Vertineks

Bosh aylanishida Vertineks: vestibulyar disfunksiya va Menyer kasalligi

Belyakova I.A. va b., Otorinolaringologiya instituti (Kiyev), 2015

Nima o'rganilgan: 50 bemor (28–65 yosh), I–III darajali vestibulyar disfunksiya va Menyer kasalligi.

Natija: Subyektiv va obyektiv simptomlar 7-kundayoq kamaygan; preparat bu bemorlar uchun tavsiya etilgan.

Vrachga qanday aytish: "Bosh aylanishi bir haftada kamayadi — LOR va nevrolog uchun."

MAQOLA · Neyrokobal

Bel sohasidagi surunkali og'riq: metilkobalamin

Chiu C.K. va b., Singapore Med J, 2011 (sharh)

Nima o'rganilgan: Ikki tomonlama yashirin RKT: 20–65 yosh, >6 oy bel og'rig'i; metilkobalamin 500 mkg m/i, 6 in'eksiya, platsebo bilan.

Natija: ODI 64→47, VAS 56,0→38,6 (p<0,05); paratsetamol ehtiyoji kamaygan.

Vrachga qanday aytish: Diqqat: tadqiqotda IN'EKSIYA ishlatilgan; Neyrokobal tabletkasi uchun to'g'ridan-to'g'ri dalil emas.

MAQOLA · Neyrokobal

Metilkobalaminning neyropatik og'riqda spruting'ga ta'siri

Mutiawati E. va b. (Indoneziya)

Nima o'rganilgan: Hayvon tajribasi: 20 kalamush, nerv bog'langandan keyin.

Natija: Metilkobalamin guruhida spruting nazoratga nisbatan kam.

Vrachga qanday aytish: Hayvon tajribasi — mexanizmni tushuntirish uchun.

MAQOLA · Neyrokobal

Metilkobalaminning potensial afzalliklari (sharh)

Gupta J.K., Qureshi S.S., 2015

Nima o'rganilgan: Metilkobalamin bo'yicha sharh.

Natija: Mielin, neyron funksiyasi va qon hosil bo'lishi uchun zarur; neyropatik simptomlarni yaxshilaydi; B vitaminlari bilan kombinatsiya samaraliroq bo'lishi mumkin.

Vrachga qanday aytish: "Faol B12 — vegetarianlar va so'rilish buzilganlarda ham."

MAQOLA · Neyrokobal

Periferik neyropatiya: patogenez va alternativ davo

Head K.A.

Nima o'rganilgan: Periferik neyropatiyada alternativ vositalar sharhi.

Natija: Alfa-lipoy kislota, atsetil-L-karnitin, benfotiamin, metilkobalamin, kapsaitsin — eng ko'p o'rganilganlar qatorida.

Vrachga qanday aytish: "Metilkobalamin — neyropatiyada eng ko'p o'rganilgan vositalardan biri."

MAQOLA · Zardeks (umumiy)

Essensial tremor davosi: AAN ko'rsatmasi yangilanishi

Zesiewicz va b., Neurology 2011 (sharh)

Nima o'rganilgan: Essensial tremor bo'yicha dalillarga asoslangan tavsiyalar.

Natija: A daraja: propranolol, primidon; B daraja: alprazolam, atenolol, GABAPENTIN (monoterapiya), sotalol, topiramat.

Vrachga qanday aytish: "Essensial tremorda gabapentin B darajali dalilga ega."

MAQOLA · Serrata

Serratiopeptidaza: jarrohlik amaliyotida qo'llash

Sharh maqola

Nima o'rganilgan: Proteolitik fermentning yallig'lanish jarayonidagi o'rni.

Natija: Shish va yallig'lanish jarayonining yakunlanishini tezlashtiradi, antibiotiklarning o'choqqa kirishini yaxshilaydi; NYaQP/steroidlardan farqli ravishda tiklanishni bostirmaydi.

Vrachga qanday aytish: "Operatsiyadan keyin shishni tez qaytaradi."

B. Atamalar lug'ati

Ensefalopatiya
Bosh miyaning diffuz shikastlanishi va hujayralar nobud bo'lishini ifodalovchi simptomlar majmui; sababi — miya hujayralarining birlamchi shikastlanishi yoki qon bilan ta'minlanish yetishmovchiligi.

Ensefalit
Bosh miyaning yallig'lanishi bilan kechadigan kasalliklar guruhi ("-it" — yallig'lanish).

Miyelit
Orqa miyaning yallig'lanishi; miya va tana o'rtasidagi signallar o'tishini buzadi.

Anosmiya
Hid bilish qobiliyatining yo'qolishi.

Giyen-Barre sindromi
O'tkir autoimmun yallig'lanishli poliradikulonevropatiya: sust parezlar, sezgi va vegetativ buzilishlar.

Parez
Harakat yo'li yoki periferik nerv shikastlanishi natijasida mushak kuchining pasayishi.